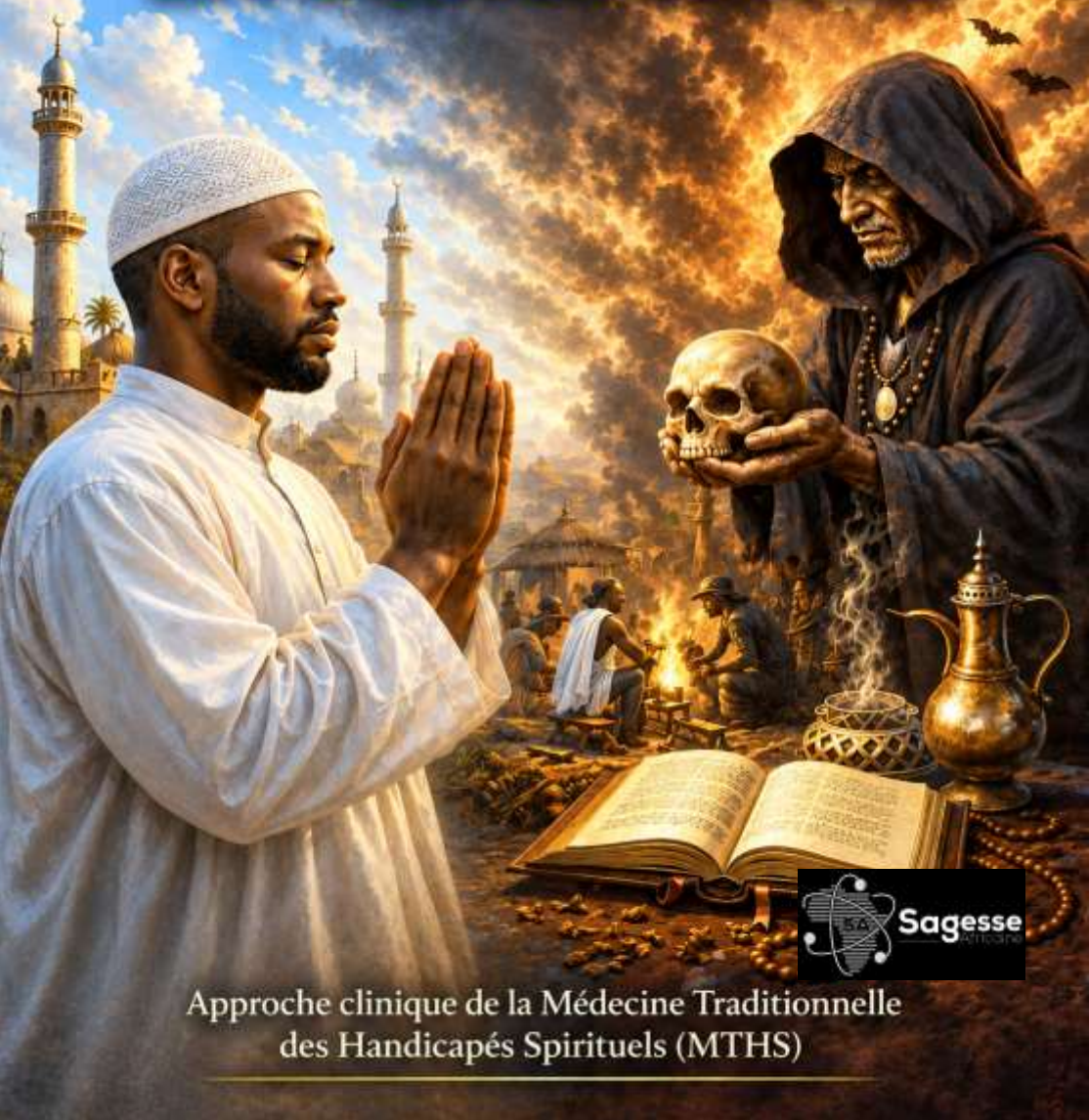


Association Mariale d'Abili (ASMAB)

LE MUSULMAN — FACE À — LA SORCELLERIE



Approche clinique de la Médecine Traditionnelle
des Handicapés Spirituels (MTHS)

Association Mariale d'ABILI

LE MUSULMAN FACE À LA SORCELLERIE

*Approche clinique de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels
(MTHS)*

Tous les droits de traduction, de reproduction et d'adaptation
Réservés pour tous les pays.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print,
microfilm, or other means without permission from the publisher.

By Sagesse Africaine, (Cameroun 2026).

📍 **Siège Social : Yaoundé – Cameroun**

☎ **Téléphones : (00237) 641 42 99 18 / (00237) 677 75 73 56**

✉ **E-mail : contact@sagesseafricaine.org**

🌐 **Site web : <https://www.sagesseafricaine.org>**

« Ô vous qui êtes éprouvés et fatigués par les épreuves de la vie, tournez-vous vers Allah avec confiance et humilité : Il soulagera vos cœurs, apaisera vos peines et allégera vos fardeaux. »

COLLECTION:

LUMIÈRE ET VÉRITÉ SUR LE MONDE DES TÉNÉBRES

Pour la promotion de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)

- 1- Ange ou Démon ? *La nature spirituelle profonde de l'Homme;*
- 2- La Vie nocturne du Sorcier (L'Univers astral de la sorcellerie);
- 3- Les Dix Commandements de Satan;
- 4- Le Satanisme et la dérive du Monde
- 5- La transmission de la Sorcellerie au sein de la famille;
- 6- La Sorcellerie au-dessus de la Foi
- 7-Comment vivre-ensemble avec des sorciers et préserver la paix en famille
- 8- Chrétien africain et la Maladie (Approche de la pastorale des malades))
- 9- Le Chrétien africain face à la Sorcellerie (Approche clinique de la MTHS);
- 10- Le Musulman face à la sorcellerie (Approche de la MTHS)
- 11- Le Bouddhiste face à la sorcellerie et au Satanisme
- 12- Hindouisme et Déviance spirituelle
- 13- La Religion traditionnelle chinoise face à la sorcellerie
- 14- La guerre des spiritualités en Afrique
- 15- Enjeux et défis du contrôle spirituel de l'Homme par les Sociétés Secrètes
- 16- La Puissance Spirituelle du Sexe
- 17- Comment comprendre et interpréter le rêve ?
- 18- Les conséquences du phénomène de Maris et Femmes de nuit
- 19- Les conséquences de la masturbation et de la pornographie dans ta vie
- 20- L'Avenir des traditions ancestrales africaines et le christianisme: Mariage ou divorce
- 21-Comment te soigner des persécutions spirituelles et de la sorcellerie
- 22- Comment obtenir ta Délivrance et ta Victoire sur le Diable, les Démons et les Sorciers
- 23- L'envoûtement par la bible et les objets liturgiques,
- 24-Culture de la paix et lutte contre la déviance spirituelle dans le monde
- 25- L'Hygiène de l'âme.
- 26- La Vie après la mort

« Allah est le Protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. »

Sourate Al-Baqara (2:257) :

SOMMAIRE

Préface.....	P.07
Avant-propos.....	P.09
INTRODUCTION.....	P.11
PARTIE-I : COMPRENDRE AVANT DE SOIGNER.....	P.13
<u>Chapitre -1</u> : Sorcellerie et univers musulman africain.....	P.14
<u>Chapitre-2</u> : Sorcellerie dans le Coran et la Sunna.....	P.21
<u>Chapitre-3</u> : Islam, culture et monde invisible.....	P.27
PARTIE-II : IDENTIFIER LE HANDICAP SPIRITUEL.....	P.35
<u>Chapitre-4</u> : Peur, foi fragilisée et rupture du tawakkul.....	P.36
<u>Chapitre-5</u> : Le handicap spirituel en contexte musulman.....	P.50
<u>Chapitre-6</u> : Conséquences sociales et religieuses.....	P.57
PARTIE-III : LA MTHS COMME OUTIL CLINIQUE.....	P.65
<u>Chapitre-7</u> : Fondements cliniques de la MTHS.....	P.66
<u>Chapitre-8</u> : Diagnostic différentiel MTHS-ISLAM.....	P.74
<u>Chapitre-9</u> : Compatibilité MTHS ET TAWHID.....	P.83
PARTIE-IV : SOIGNER SANS MANIPULER.....	P.92
<u>Chapitre-10</u> : Accueil clinique et alliance thérapeutique.....	P.93
<u>Chapitre-11</u> : Thérapie spirituelle islamique encadrée.....	P.100
<u>Chapitre-12</u> : Approche symbolique et restauration intérieure.....	P.118
PARTIE-V : GUÉRIR, RÉINTÉGRER, PRÉVENIR.....	P. 136
<u>Chapitre-13</u> : Accompagnement psychosocial et communautaire.....	P.137
<u>Chapitre-14</u> : Études de cas cliniques en MTHS.....	P.147
<u>Chapitre-15</u> : Prévention durable et responsabilité religieuse en MTHS...P.157	
<u>Chapitre-16</u> : Guide de formation des imams et leaders communautaires en MTHS.....	P.164
Conclusion générale du livre.....	P.176
ANNEXES CLINIQUES - MTHS islamique.....	P.185

PRÉFACE

La sorcellerie occupe une place singulière dans l'imaginaire et l'expérience des sociétés africaines, y compris au sein des communautés musulmanes. Elle est souvent évoquée avec crainte, parfois exploitée à des fins religieuses ou sociales, et trop rarement abordée comme ce qu'elle est fondamentalement pour ceux qui en souffrent : **une expérience humaine de détresse, de déséquilibre et de vulnérabilité spirituelle**. Derrière les récits de sortilèges, de jinn ou d'attaques invisibles, se trouvent des hommes, des femmes et des familles fragilisés, pris dans la peur, la culpabilité et l'isolement.

Cet ouvrage prend délibérément ses distances avec toute approche spectaculaire ou émotionnelle de la sorcellerie. Il ne s'agit ni de nourrir la peur, ni de transformer la souffrance spirituelle en démonstration religieuse. Le choix méthodologique posé ici est clair : considérer la sorcellerie d'abord comme une **souffrance humaine nécessitant écoute, discernement et soin**, et non comme un champ d'affrontement religieux ou de performance rituelle.

Dans cette perspective, une **approche clinique islamo-compatible** s'impose. L'Islam reconnaît l'existence du monde invisible, tout en plaçant la dignité de la personne humaine, la responsabilité individuelle et la confiance en Allah au cœur de la vie spirituelle. Toute prise en charge qui ignorerait ces principes risquerait soit de nier la souffrance vécue, soit de la détourner vers des pratiques contraires au tawḥīd. Ce livre s'inscrit résolument dans le respect de la théologie islamique, en distinguant

soigneusement l'épreuve spirituelle, la peur pathologique, la manipulation religieuse et les troubles relevant d'un accompagnement médical ou psychologique.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS), telle qu'elle est présentée dans ces pages, ne se veut ni un système de croyances parallèles ni une forme de magie déguisée. Elle est un **outil clinique de compréhension et d'accompagnement**, enraciné dans l'anthropologie africaine, structuré par une démarche diagnostique rigoureuse, et orienté vers la restauration de l'équilibre spirituel, psychique et social de la personne. La MTHS ne combat pas l'invisible par l'invisible, mais la peur par le sens, la confusion par le discernement et la souffrance par le soin.

En proposant une lecture apaisée et responsable de la sorcellerie en contexte musulman africain, cet ouvrage invite imams, accompagnateurs spirituels, professionnels du soin et fidèles à dépasser les réactions instinctives de rejet ou de fascination. Il appelle à une **éthique de l'accompagnement** fondée sur la miséricorde, la connaissance et la prudence, afin que la foi ne devienne jamais un instrument de domination ou de culpabilisation.

Puisse ce livre contribuer à ouvrir un espace nouveau où la parole se libère, où la peur recule et où la foi, solidement enracinée dans l'Islam, redevient un chemin de paix intérieure, de lucidité et de dignité retrouvée.

AVANT-PROPOS

Ce livre est né d'un constat douloureux et répété : dans de nombreuses sociétés africaines à majorité ou à forte présence musulmane, la sorcellerie continue de produire des ravages silencieux. Elle n'apparaît pas seulement dans les discours ou les récits populaires, mais dans les trajectoires brisées, les peurs persistantes, les soupçons familiaux et les détresses spirituelles profondes. Trop souvent, ces souffrances sont mal nommées, mal comprises et mal prises en charge.

Face à ces réalités, le musulman africain se trouve fréquemment **désarmé**. D'un côté, une foi sincère, héritée et respectée, mais parfois insuffisamment accompagnée pour faire face aux peurs liées au monde invisible. De l'autre, des pratiques traditionnelles ou des discours religieux abusifs qui exploitent la crainte de la sorcellerie, fragilisant davantage les personnes au lieu de les guérir. C'est dans cet espace de tension que s'inscrit le présent ouvrage.

Le Musulman face à la Sorcellerie ne prétend ni trancher des débats théologiques complexes, ni proposer des solutions miraculeuses. Son ambition est plus humble et plus exigeante : offrir une **lecture clinique, humaine et responsable** de la sorcellerie, envisagée comme une souffrance spirituelle et psychosociale avant d'être un objet de polémique religieuse. Il s'agit de déplacer le regard, de la fascination pour l'invisible vers l'attention portée à la personne qui souffre.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) constitue le cadre méthodologique de cette réflexion. Elle part du principe que certaines détresses ne relèvent ni exclusivement de la médecine biomédicale, ni uniquement de l'accompagnement religieux classique. Elles se situent à l'intersection du spirituel, du psychique, du culturel et du social. La MTHS ne s'inscrit pas dans une logique magique ou rituelle, mais dans une démarche de **diagnostic, de discernement et d'accompagnement thérapeutique**, compatible avec les fondements de l'Islam et respectueuse du tawhīd.

Ce livre s'adresse d'abord aux musulmans confrontés à la peur de la sorcellerie, afin de les aider à retrouver une foi apaisée, lucide et confiante. Il s'adresse également aux imams, enseignants coraniques, accompagnateurs spirituels, professionnels de la santé et acteurs communautaires, appelés à écouter, orienter et protéger les personnes en détresse sans les enfermer dans des interprétations culpabilisantes ou violentes. L'approche proposée refuse les raccourcis dangereux : elle distingue l'épreuve spirituelle de la pathologie, la croyance culturelle de la manipulation religieuse, et la foi authentique de la peur paralysante. Elle invite à une responsabilité partagée, où le soin devient un acte de miséricorde et de justice, et non un lieu de domination ou de spectacle religieux.

En définitive, cet ouvrage est une invitation à **réconcilier foi, raison et humanité**. Il appelle à un Islam africain capable d'affronter les réalités du monde invisible sans céder à la peur, de protéger les plus vulnérables sans les stigmatiser, et de faire de la foi un chemin de guérison intérieure, de paix sociale et de dignité retrouvée.

INTRODUCTION

En Afrique contemporaine, la sorcellerie n'appartient ni au registre du folklore ni à celui de l'imaginaire collectif. Elle constitue une expérience sociale et spirituelle vécue, redoutée, parfois instrumentalisée, qui traverse les familles, façonne les relations communautaires et imprime sa marque sur les consciences. Dans ce paysage invisible mais agissant, le musulman africain se trouve souvent à la croisée de plusieurs mondes : la Révélation coranique, l'héritage des savoirs traditionnels, et les blessures silencieuses engendrées par les agressions spirituelles. C'est dans cet entrelacs de foi, de culture et de souffrance que s'inscrit le présent ouvrage.

Le Musulman face à la sorcellerie propose une lecture clinique et théologique de ces réalités à travers la **Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)**. Loin de toute approche sensationnaliste, cette démarche s'attache à nommer, comprendre et accompagner les formes de vulnérabilité spirituelle qui affectent l'être humain dans sa totalité : corps, âme, esprit et inscription sociale. La sorcellerie y est abordée non comme un simple acte occulte, mais comme un phénomène pathogène, générateur de déséquilibres profonds, appelant une réponse thérapeutique intégrale.

Ancré dans la théologie islamique, nourri par la sagesse soufie et éclairé par l'anthropologie médicale africaine, cet ouvrage se déploie comme un itinéraire initiatique. Il conduit le lecteur des ténèbres de la peur et de la confusion vers la clarté du

discernement spirituel (*furqān*), de la guérison et de la paix intérieure. À mesure que les pages se tournent, le musulman n'est plus seulement une victime ou un spectateur : il devient sujet de sa libération, réconciliant la science du cœur (*'ilm al-qalb*) avec les exigences de la foi vécue.

Destiné à la lecture des Musulmans d'Afrique, ce livre se veut un pont : entre tradition et révélation, entre souffrance et espérance, entre la nuit des atteintes invisibles et l'aube d'une restauration spirituelle. Il invite à penser la délivrance de l'emprise du phénomène de la sorcellerie non comme une rupture brutale, mais comme un chemin, lent et sacré, où la miséricorde divine restaure ce que la peur avait fragmenté.

PARTIE-I :

COMPRENDRE AVANT DE SOIGNER

(Fondements anthropologiques et théologiques de la méthodologie)

CHAPITRE -1 :

SORCELLERIE ET UNIVERS MUSULMAN AFRICAIN

INTRODUCTION

Entrer dans la nuit pour comprendre la lumière

Dans l'Afrique musulmane, lorsque le soleil décline et que les ombres s'allongent, un autre monde semble s'éveiller. Les anciens disent que la nuit n'est jamais vide : elle est peuplée de présences, de mémoires, de forces silencieuses qui observent les vivants. Dans les concessions familiales, sous les toits de tôle ou de chaume, les voix se font plus basses à mesure que la pénombre gagne. Les enfants sont rappelés à l'ordre, les portes se ferment, et les adultes échangent des regards chargés de sens. La nuit est un seuil.

C'est dans ce seuil que surgissent les premières questions cliniques : pourquoi ce corps ne dort-il plus ? Pourquoi ce rêve revient-il avec insistance ? Pourquoi cette maladie échappe-t-elle à toute explication ordinaire ? Très vite, un mot s'impose, lourd de crainte et d'héritage : **sorcellerie**.

Pour le musulman africain, cette notion ne relève pas d'un folklore marginal. Elle s'inscrit dans une vision du monde où le **visible et l'invisible sont continuellement en interaction**, où Allah demeure le Maître absolu de toute chose, mais où existent

aussi des créatures cachées — les **djinns** — capables d'interférer dans la vie humaine, et des actes interdits (*sihr*) susceptibles de provoquer le mal.

Ce chapitre se veut un **temps d'arrêt**, un espace de discernement. Avant toute délivrance, avant toute récitation, avant toute intervention, il faut comprendre. Comprendre comment la peur se structure, comment la croyance façonne le symptôme, comment la culture donne un langage à la souffrance. C'est là la fonction méthodologique fondamentale de ce premier chapitre dans la perspective de la **Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)**.

I. L'ISLAM AFRICAIN : UNE FOI ENRACINEE DANS UNE COSMOLOGIE VIVANTE

1. Une rencontre historique sans rupture ontologique

L'islam, en Afrique noire, n'est pas né d'une rupture brutale avec les univers spirituels antérieurs. Il est arrivé par étapes, porté par des commerçants, des érudits, des maîtres soufis. Il a rencontré des sociétés où le monde était déjà perçu comme un tissu de relations visibles et invisibles.

Dans ces sociétés, la maladie, la stérilité, l'échec ou la mort prématurée n'étaient jamais perçus comme de simples accidents. Ils étaient lus comme des **signaux**, des déséquilibres, des appels à interprétation. L'islam n'a pas détruit cette lecture ; il l'a **reconfigurée** à travers le langage coranique.

Les anciens esprits des lieux ont été relus comme des djinns. Les interdits ancestraux ont été reformulés en catégories de licite (*ḥalāl*) et d'illicite (*ḥarām*). Les rites de protection ont été islamisés par des versets, des invocations et des amulettes écrites. Ainsi s'est constitué un **islam africain incarné**, profondément préoccupé par la protection spirituelle de l'individu et du groupe.

2. Le monde invisible comme donnée quotidienne

Dans cet islam vécu, l'invisible n'est pas un concept abstrait. Il est expérimenté à travers les rêves, les intuitions, les maladies étranges, les accidents répétés. Le Coran lui-même confirme cette dimension en évoquant les djinns comme des créatures réelles, dotées de libre arbitre.

Nier l'invisible serait, pour beaucoup de musulmans africains, nier une part du message coranique. Mais absolutiser l'invisible, c'est risquer de transformer la foi en une peur permanente. Toute la clinique spirituelle se joue dans cet **équilibre fragile**.

II. LE **SIHR** : ENTRE REVELATION ET IMAGINATION SOCIALE

1. Fondement scripturaire et légitimation de la peur

Le Coran évoque explicitement la sorcellerie, notamment dans le récit des anges de Babylone. Il en affirme l'existence tout en la condamnant sans ambiguïté. Cette reconnaissance scripturaire donne à la sorcellerie une **existence ontologique** dans la conscience musulmane.

Dans l'Afrique musulmane, cette donnée est renforcée par les récits locaux : histoires de familles divisées, de jalousies mortifères, de pactes nocturnes. Le *sihr* devient alors la clé d'interprétation privilégiée des maux persistants.

2. Scène clinique 1 – Le jeune commerçant entravé

Un homme d'une trentaine d'années consulte. Depuis l'ouverture de son commerce, tout s'effondre. Les clients se raréfient, les marchandises se perdent, les rêves se peuplent de poursuites nocturnes. Dans son discours, un nom revient : celui d'un oncle jaloux.

Cliniquement, le symptôme n'est pas seulement économique. Il est **existentiel**. L'homme doute de sa valeur, de sa protection divine. La sorcellerie devient le récit qui donne cohérence à l'échec.

III. LA PEUR COMME MATRICE DU HANDICAP SPIRITUEL

1. Apprendre à avoir peur

La peur de la sorcellerie s'inculque dès l'enfance. Elle est transmise par les contes, les avertissements, les interdits nocturnes. Elle structure l'imaginaire bien avant l'apparition du symptôme.

Cette peur est socialement fonctionnelle : elle protège, régule, avertit. Mais lorsqu'elle devient omniprésente, elle se transforme en **agent pathogène**.

2. Scène clinique 2 – La femme qui ne dort plus

Une femme d'une quarantaine d'années décrit des réveils nocturnes accompagnés d'une sensation d'écrasement. Elle est persuadée qu'un djinn s'assoit sur sa poitrine. Son corps est fatigué, son esprit épuisé.

Dans la MTHS, cette plainte n'est pas disqualifiée. Elle est accueillie comme un langage symbolique de l'angoisse et de la peur intériorisée.

IV. QUAND LA CROYANCE DEVIENT SYMPTOME INCARNE

1. Le corps comme espace narratif

Dans l'anthropologie médicale africaine, le corps raconte ce que la parole ne peut exprimer. Les douleurs, les paralysies, les troubles fonctionnels sont des **messages codés**.

2. Scène clinique 3 – Le rêve d'attachement

Un jeune homme raconte des rêves récurrents de mariage nocturne. Il se réveille épuisé, convaincu d'être lié à une entité invisible. Ce récit oriente toute sa demande de soin.

V. REVE, NUIT ET ESPACE THERAPEUTIQUE

Le rêve occupe une place centrale dans l'univers musulman africain. Il est perçu comme un lieu de vérité, mais aussi de

vulnérabilité. Les attaques nocturnes sont redoutées, car elles échappent au contrôle conscient.

VI. ITINERAIRES THERAPEUTIQUES ET FIGURES DE MEDIATION

1. Le marabout : médiateur ambivalent

Le marabout est souvent le premier recours. Il incarne le savoir religieux et la protection, mais parfois aussi la crainte d'une proximité excessive avec l'occulte.

2. Scène clinique 4 – La surcharge rituelle

Un patient arrive couvert de talismans, ayant multiplié bains et sacrifices. Son univers spirituel est saturé, son esprit confus.

VII. L'ANAMNESE CULTURELLE EN MTHS

1. Accueillir sans juger

L'anamnèse commence par l'écoute du récit du mal. Le patient doit pouvoir dire sans être corrigé immédiatement.

2. Cartographie symbolique

Le thérapeute identifie peurs, croyances, figures accusées, pratiques antérieures.

VIII. Discernement théologique et délivrance

1. Le Tawhīd comme socle clinique

Toute prise en charge vise la restauration de l'unicité divine dans la conscience du patient.

2. La *ruqya* comme réalignement

La récitation coranique agit comme un rappel, non comme une magie.

IX. VERS UNE CLINIQUE ISLAMO-AFRICAINE INTEGREE

La sorcellerie apparaît ici comme un **langage de la souffrance spirituelle**. La comprendre permet d'éviter les excès et d'ouvrir un chemin de libération intégrale.

Ce chapitre, dense et fondateur, prépare le lecteur à entrer dans l'analyse détaillée des handicaps spirituels et des processus thérapeutiques proposés par la MTHS en contexte musulman africain.

CHAPITRE-2 :

SORCELLERIE DANS LE CORAN ET LA SUNNA

INTRODUCTION

Quitter la confusion pour entrer dans la clarté

Après avoir longuement marché dans les paysages nocturnes de la peur, des récits hérités et des symptômes chargés de symboles, le pèlerin du soin spirituel atteint un seuil décisif. Ce seuil n'est pas géographique, mais intérieur. Il marque le passage de l'expérience brute à l'intelligence spirituelle, de l'émotion à la doctrine, de la peur diffuse à la clarté structurante de la Parole révélée.

Dans l'univers musulman africain, la sorcellerie est rarement niée. Elle est vécue, racontée, redoutée. Mais ce qui fait souffrir plus encore que l'atteinte elle-même, c'est la **confusion doctrinale** qui l'entoure : confusion entre la puissance d'Allah et les forces occultes, confusion entre protection et dépendance rituelle, confusion entre délivrance et magie religieuse.

Ce chapitre s'inscrit comme un **rite de purification intellectuelle et spirituelle**. Il a pour vocation de distinguer, de trier, de remettre chaque chose à sa place. Car il n'existe pas de véritable délivrance sans une foi éclairée, et il n'existe pas de soin spirituel sans limites théologiques clairement établies.

I. LA RECONNAISSANCE CORANIQUE DE LA SORCELLERIE : UNE PEDAGOGIE DIVINE

1. Une reconnaissance sans fascination

Le Coran adopte une posture d'une grande finesse : il reconnaît l'existence de la sorcellerie sans jamais en faire le centre du discours spirituel. Le *siḥr* est mentionné, mais toujours dans une perspective critique, éducative et limitative.

Cette reconnaissance est essentielle sur le plan clinique. Elle empêche de disqualifier la souffrance du croyant en la réduisant à une illusion. Mais elle empêche tout autant de sacraliser la sorcellerie en lui attribuant un pouvoir autonome.

La Révélation enseigne ainsi une **voie médiane** : ne pas nier, ne pas absolutiser.

2. Le récit de Babylone (Sourate 2, verset 102)

Le récit de Hārūt et Mārūt constitue la pierre angulaire de la doctrine islamique sur la sorcellerie. Il montre que le *siḥr* est un savoir dévoyé, une connaissance utilisée sans crainte de Dieu. Il insiste surtout sur un point capital : « *Ils ne nuisent à personne qu'avec la permission d'Allah.* » Ce verset est d'une portée thérapeutique immense. Il signifie que toute atteinte spirituelle reste **sous la souveraineté divine**. Aucune force, aucun djinn, aucun sorcier n'agit en dehors du décret d'Allah.

II. LA SUNNA : LE PROPHETE COMME MODELE DE GESTION DE L'EPREUVE SPIRITUELLE

1. L'épreuve prophétique de la sorcellerie

La tradition rapporte que le Prophète Muhammad (paix et salut sur lui) fut affecté par un acte de sorcellerie. Cet épisode est fondamental, car il déconstruit une croyance répandue : celle selon laquelle la foi authentique rendrait totalement invulnérable.

Le Prophète n'a ni nié l'épreuve, ni paniqué, ni cherché une solution magique. Il s'est tourné vers Allah, a renforcé sa pratique spirituelle et a suivi la voie de la patience et de la confiance.

2. Enseignements cliniques de la Sunna

Sur le plan de la MTHS, cet épisode enseigne que l'épreuve spirituelle n'est pas nécessairement le signe d'un péché caché ou d'une foi défaillante. Elle peut être un **lieu de purification**, de réajustement intérieur et de croissance.

III. LES SOURATES DE PROTECTION : RECENTRAGE ET NON FETICHISATION

Les sourates al-Falaq et an-Nās, ainsi que le verset du Trône (Ayat al-Kursi), occupent une place centrale dans la Sunna. Elles sont récitées comme des actes de confiance et de remise de soi.

Dans la clinique africaine, le risque est de transformer ces récitation en **objets magiques**. La clarification doctrinale consiste

à rappeler que leur efficacité ne réside pas dans une formule, mais dans la relation vivante à Allah.

IV. FOI AUTHENTIQUE ET CROYANCES DEFORMEES EN CONTEXTE AFRICAIN

1. L'hybridation religieuse

L'islam africain, dans sa vitalité, a parfois absorbé des pratiques issues des religions traditionnelles : amulettes non coraniques, sacrifices dissimulés, pactes de protection. Ces pratiques naissent souvent de la peur et du désir de contrôle.

2. Scène clinique – Le croyant aux protections multiples

Un homme connu pour sa piété consulte. Il prie, jeûne, récite le Coran, mais porte en permanence plusieurs talismans. Il avoue qu'il ne se sent en sécurité qu'à travers eux. La foi est présente, mais **désaxée**. Le travail thérapeutique consistera à restaurer la confiance directe en Allah, sans humilier ni brusquer.

V. LE *SHIRK* : FRONTIERE INFRANCHISSABLE DU SOIN SPIRITUEL

1. Comprendre le *shirk* au-delà de la théorie

Le *shirk* n'est pas toujours une adhésion consciente à une autre divinité. Il peut être fonctionnel : attribuer un pouvoir autonome à un objet, à un marabout, à un rituel.

2. Le *shirk* comme pathologie spirituelle

Dans la MTHS, le *shirk* est compris comme un facteur aggravant du handicap spirituel. Il fragilise la foi, alimente la peur et installe une dépendance thérapeutique.

VI. POSER LES LIMITES THEOLOGIQUES DU SOIN

1. Le cadre licite de la délivrance

L'islam autorise et encourage la prière, l'invocation, la récitation coranique, le repentir, l'aumône et l'accompagnement communautaire.

2. Les pratiques interdites

Toute pratique impliquant pacte, sacrifice occulte, appel aux djinns ou promesse de puissance est exclue.

VII. CLARIFICATION DOCTRINALE ET ANAMNESE EN MTHS

La clarification doctrinale fait partie intégrante de l'anamnèse. Le thérapeute évalue la compréhension de la foi, les confusions et les peurs.

VIII. SCENES CLINIQUES DE DERIVES THERAPEUTIQUES

1. Le patient prisonnier du rituel

Un homme ne peut plus prendre de décision sans consulter un marabout. Sa vie est paralysée.

2. La femme enfermée dans la culpabilité

Convaincue d'être attaquée, elle multiplie les rites jusqu'à l'épuisement.

IX. LA DELIVRANCE COMME RETOUR A L'UNICITE

La délivrance n'est pas un combat spectaculaire contre des forces invisibles. Elle est un **retour progressif et apaisé à l'axe du Tawḥīd**.

X. VERS UNE CLINIQUE DE LA FOI ECLAIREE

Ce chapitre agit comme un filtre purificateur. Il protège le croyant contre les dérives, sécurise la démarche thérapeutique et prépare l'entrée dans l'analyse détaillée des atteintes spirituelles.

Clarifier, ici, c'est déjà délivrer. Et c'est sur cette base solide que pourra s'édifier une véritable clinique islamo-africaine de la guérison spirituelle.

CHAPITRE-3 :

ISLAM, CULTURE ET MONDE INVISIBLE

INTRODUCTION

Diagnostic différentiel

Dans les sociétés musulmanes d'Afrique noire, l'apprentissage de la foi ne commence jamais dans l'abstraction. Il commence dans un monde déjà habité, déjà interprété, déjà chargé de récits. Avant même que l'enfant n'apprenne à réciter la Fātiḥa, il apprend à reconnaître les signes du danger invisible, à craindre les intentions cachées, à se méfier des jalousies muettes. Ainsi, l'entrée dans l'islam se fait rarement sur une terre vierge : elle s'opère dans un paysage spirituel dense, où l'invisible précède souvent le dogme.

Or, le Coran lui-même reconnaît cette densité du monde invisible. Il rappelle que la création ne se limite pas à ce que l'œil perçoit : « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent » (Coran 51, 56). Cette parole, souvent citée dans les cercles de science religieuse, prend en Afrique une résonance particulière. Elle confirme que l'homme n'est pas seul dans l'univers, mais elle impose aussitôt une hiérarchie : l'adoration n'appartient qu'à Allah, et nul autre ne peut être craint, sollicité ou invoqué comme source autonome de pouvoir.

C'est précisément dans cette tension que naît la problématique clinique que ce chapitre explore. Car si l'islam affirme l'existence du monde invisible, il en redéfinit radicalement le sens. Il ne s'agit plus d'un espace flou où toutes les forces se valent, mais

d'un ordre créé, soumis à la souveraineté absolue d'Allah. Lorsque cette distinction se brouille, lorsque la culture reprend le dessus sur la norme révélée, l'invisible devient source de peur plutôt que de confiance, de dépendance plutôt que de libération.

Dans la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS), le prologue initiatique consiste précisément à réapprendre à voir. Voir sans nier. Voir sans absolutiser. Voir sans se soumettre à la fascination. Comme le rappelle le Coran : « Allah fait sortir ceux qui croient des ténèbres vers la lumière » (Coran 2, 257). Cette sortie n'est pas seulement morale ; elle est aussi cognitive, symbolique et thérapeutique.

I. L'ISLAM AFRICAIN AU CARREFOUR DES MONDES

1. Une foi révélée dans des univers déjà habités

Lorsque l'islam s'est diffusé en Afrique noire, il n'est pas arrivé dans un vide spirituel. Il a rencontré des sociétés structurées par une cosmologie ancienne, où le monde visible et le monde invisible s'interpénètrent sans cesse. Les ancêtres, les génies territoriaux, les forces de la nature et les esprits errants faisaient déjà partie de l'horizon explicatif du malheur, de la maladie et de l'échec.

L'inculturation islamique ne consiste donc pas à nier cet héritage, mais à le traverser, à le purifier et à le réordonner. Le Coran adopte lui-même cette pédagogie : il ne nie pas l'existence des djinns, ni celle de l'action malveillante d'autrui, mais il en fixe

strictement les limites. « Ils ne peuvent nuire à personne sans la permission d'Allah » (Coran 2, 102). Cette affirmation est centrale dans le diagnostic différentiel MTHS, car elle permet de mesurer le degré de déséquilibre spirituel d'un patient : plus la peur attribue aux forces invisibles un pouvoir autonome, plus le handicap spirituel est profond.

Dans les villages comme dans les quartiers urbains, l'islam africain s'est ainsi incarné dans des pratiques quotidiennes mêlant prières, invocations, récitations coraniques et gestes hérités de la tradition. Certaines de ces pratiques relèvent d'une adaptation culturelle saine ; d'autres, en revanche, glissent vers un syncrétisme pathogène lorsque la confiance en Allah est remplacée par la peur des hommes ou des esprits.

2. Le monde invisible comme lieu d'épreuve et de responsabilité

Contrairement à certaines représentations culturelles où l'invisible est un espace arbitraire, l'islam le présente comme un lieu d'épreuve morale. Les djinns, comme les humains, sont responsables de leurs actes. Ils ne sont ni des dieux, ni des forces fatales. Le Coran rapporte même leur écoute attentive de la Révélation : « Nous avons entendu une Lecture merveilleuse qui guide vers la droiture » (Coran 72, 1–2).

Cette vision transforme radicalement l'approche thérapeutique. Dans une scène clinique fréquente, un patient affirme être “pris” ou “habité” par une force invisible. Le travail du

praticien MTHS n'est pas de confirmer immédiatement cette interprétation, mais de la réinscrire dans la hiérarchie islamique : si une atteinte existe, elle ne supprime jamais la responsabilité, ni la possibilité de recours à Allah.

Dans l'Afrique musulmane, cette relecture est souvent un soulagement. Elle permet de sortir d'une vision fataliste où l'homme est condamné à subir les attaques invisibles sans recours. Comme le rappelle le Coran : « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur » (Coran 33, 3). Cette confiance devient un critère clinique : lorsqu'elle est

II. L'ISLAM AFRICAIN AU CARREFOUR DES MONDES

1. Une foi vécue dans un univers relationnel

Dans de nombreuses sociétés d'Afrique noire, l'individu n'existe jamais seul. Il est toujours situé dans un réseau de relations : famille, lignage, ancêtres, communauté, monde invisible. L'islam, en s'implantant dans ces sociétés, a rencontré une vision du monde profondément **relationnelle**.

Ainsi, la foi n'est pas seulement une adhésion personnelle à des vérités révélées ; elle est aussi un mode de protection collective, une manière de maintenir l'équilibre entre les forces visibles et invisibles. Cette dimension explique pourquoi les questions de sorcellerie, de djinns et d'attaques mystiques occupent une place si centrale dans l'islam africain vécu.

2. Le monde invisible comme espace de médiation

Dans cette cosmologie, le monde invisible n'est pas nécessairement hostile. Il est ambivalent. Il peut protéger comme il peut nuire. Cette ambivalence prépare le terrain aux confusions, mais aussi à la richesse symbolique des récits.

II. CULTURE, RELIGION ET SYNCRETISME : CLARIFIER LES TERMES

1. La culture comme matrice symbolique

La culture fournit les images, les récits et les catégories par lesquelles une société interprète le mal. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est un **langage**.

Dans la MTHS, il est fondamental de ne pas diaboliser la culture. Ce serait priver le patient de son vocabulaire intérieur.

2. La religion comme axe normatif

La religion, en revanche, introduit une norme, une orientation, une hiérarchie. Dans l'islam, cette norme est le **Tawḥīd**. Toute pratique, toute croyance doit être évaluée à l'aune de l'unicité divine.

3. Le syncrétisme : quand les frontières s'effacent

Le syncrétisme apparaît lorsque des éléments culturels ou religieux hétérogènes sont combinés sans discernement. Il devient pathogène lorsqu'il installe la confusion, la peur et la dépendance.

III. LES SYNCRETISMES PATHOGENES EN CONTEXTE MUSULMAN AFRICAIN

1. Amulettes, talismans et objets de pouvoir

Dans de nombreux contextes, des objets sont investis d'un pouvoir protecteur autonome. Lorsqu'ils ne sont plus des rappels symboliques mais des garanties absolues, ils deviennent pathogènes.

2. Scène clinique – L'enfant saturé de protections

Un enfant arrive en consultation portant plusieurs objets protecteurs. Il est anxieux, mutique. Sa mère explique qu'elle craint une attaque mystique. Le soin commencera par une **désaturation symbolique**.

IV. MANIPULATION SOCIALE ET ECONOMIE DE LA PEUR

1. La peur comme ressource de pouvoir

La peur de la sorcellerie peut être exploitée. Certains acteurs religieux ou traditionnels construisent une autorité fondée sur la menace invisible.

2. Scène clinique – Le patient dépendant du médiateur

Un homme ne prend plus aucune décision sans consulter un intermédiaire spirituel. Sa liberté intérieure est confisquée.

V. ANTHROPOLOGIE MEDICALE AFRICAINE ET DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

1. Le symptôme comme fait social

Dans l'anthropologie médicale africaine, le symptôme est toujours lié à un contexte social. Une maladie peut exprimer un conflit, une rupture, une dette symbolique.

2. Lire le symptôme sans absolutiser l'invisible

Le diagnostic différentiel consiste à distinguer ce qui relève de l'atteinte spirituelle, de la détresse psychique, du conflit social ou de la manipulation.

VI. PREMIERE GRILLE DE DISCERNEMENT EN MTHS

1. Questions clés

- Le symptôme isole-t-il ou relie-t-il ?
- La pratique renforce-t-elle la peur ou la confiance ?
- Le médiateur renvoie-t-il à Allah ou à lui-même ?

2. Signes de dérive

- Dépendance rituelle
- Inflation des protections
- Culpabilité excessive

VII. SCENES CLINIQUES DE CONFUSION ET DE DISCERNEMENT

1. La femme enfermée dans l'accusation familiale

Elle attribue tous ses maux à un membre de sa famille. Le travail clinique consistera à élargir le champ de lecture.

2. Le jeune homme fasciné par l'invisible

Il recherche constamment des signes et des révélations. La fascination devient pathologique.

VIII. SEPARER SANS DETRUIRE : PEDAGOGIE DU DISCERNEMENT

Le rôle du thérapeute MTHS n'est pas de casser les croyances, mais de les **réordonner**. Séparer la culture de la manipulation, la foi de la peur, l'invisible de la fascination.

IX. VERS UNE CLINIQUE DU DISCERNEMENT INCARNÉ

Ce chapitre introduit une compétence essentielle : voir clair sans violence. Le diagnostic différentiel protège le patient contre les dérives et prépare un accompagnement ajusté.

Dans l'itinéraire initiatique proposé par ASMAB – Sagesse Africaine, ce discernement marque une maturité nouvelle. Le lecteur n'est plus prisonnier des récits ; il apprend à les traverser.

Ce seuil franchi, il devient possible d'entrer dans l'analyse fine des handicaps spirituels et des itinéraires thérapeutiques intégrés, sans confusion ni peur.

PARTIE-II :
IDENTIFIER LE HANDICAP SPIRITUEL
(Phase diagnostique de la méthodologie MTHS)

CHAPITRE-4 :
PEUR, FOI FRAGILISEE ET RUPTURE DU
TAWAKKUL

INTRODUCTION

SECTION-I – ANTHROPOLOGIE AFRICAINE DE LA PEUR ET
INCULTURATION ISLAMIQUE DU TAWAKKUL

Quand la peur devient un guide

Dans les sociétés africaines musulmanes, la peur n'est pas simplement un affect isolé. Elle traverse les familles, les lignages, et se manifeste dans les gestes, les silences et les rituels. Les enfants apprennent à interpréter la peur comme un signal du monde invisible avant même de comprendre les textes sacrés. Cette peur, si elle n'est pas réorientée, peut s'enraciner dans le corps et l'âme, devenant une matrice de vulnérabilité spirituelle.

Le Coran enseigne que la peur, quand elle est encadrée, peut devenir un vecteur de purification et de croissance : « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquilisent à l'évocation d'Allah : voilà ceux qui trouvent la paix » (Coran 13, 28). Ainsi, la peur n'est pas bannie, mais elle doit être intégrée dans la confiance en Allah.

1. La peur comme langage social et cosmologique

L'anthropologie médicale africaine montre que la peur est à la fois individuelle et collective. Les récits de sorcellerie, les histoires de malédictions familiales et les avertissements des anciens

circulent comme des codes symboliques. Ces récits transmettent des normes, mais parfois aussi des paniques inutiles. Dans le contexte musulman, cette peur peut entrer en tension avec la foi si elle est interprétée comme une puissance autonome au lieu d'un signe dépendant de la volonté divine.

Le diagnostic clinique MTHS commence par cette observation : la peur doit être lue, non simplement mesurée. Chaque tremblement, chaque insomnie, chaque fixation rituelle est un langage, un message codé qui traduit le déséquilibre entre le monde visible, le monde invisible et la relation à Allah.

2. Le *tawakkul* comme remède structurel

Le *tawakkul* est le principe fondamental pour réorienter la peur. Il ne s'agit pas de résignation passive, mais d'une confiance active et réfléchie : placer toutes ses affaires, ses peurs et ses projets sous la guidance et la protection d'Allah tout en agissant avec responsabilité. Le Coran le formule clairement : « Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit » (Coran 65, 3).

L'inculturation africaine de ce principe passe par l'oralité, les proverbes et les pratiques communautaires. Dans de nombreux villages, les sermons, les récitations publiques et les conseils des anciens guident le croyant à pratiquer le *tawakkul* tout en reconnaissant la réalité du monde invisible. Cette médiation culturelle est essentielle pour transformer une peur paralysante en vigilance constructive.

3. Scènes cliniques incarnées

a) L'homme des palpitations nocturnes

Un homme d'une quarantaine d'années consulte pour des palpitations nocturnes, insomnies et anxiété permanente. Il prie régulièrement, jeûne et connaît le Coran par cœur, mais chaque échec ou incident est interprété comme une attaque invisible. Le repérage clinique révèle une rupture du *tawakkul* : la prière est devenue un rituel défensif, non un acte de confiance.

b) La jeune femme saturée de talismans

Une jeune femme porte une dizaine de talismans et récite des invocations multiples chaque nuit pour se protéger des djinns et de la sorcellerie. Sa peur est telle qu'elle ne peut se concentrer sur ses études ni sur sa famille. La scène clinique révèle que la culture et la croyance se sont mêlées à une interprétation déformée du monde invisible, augmentant sa vulnérabilité spirituelle.

4. Diagnostic différentiel initial

L'étape suivante consiste à distinguer la peur liée à l'épreuve (*ibtālā*) de la peur pathologique installée. Le premier signal est la capacité du croyant à revenir à la confiance après un acte d'adoration ou un moment de rappel d'Allah. Le second se manifeste par l'obsession, la dépendance aux protections matérielles et l'angoisse continue malgré la prière.

5. Intégration narrative du Coran dans la clinique

Dans la pratique MTHS, les versets ne sont pas récités comme des formules magiques, mais intégrés dans l'accompagnement narratif. Par exemple, lorsqu'un patient est terrifié par des rêves de djinns ou de sorcellerie, le thérapeute peut rappeler : « Allah est le Meilleur Protecteur » (Coran 3, 173), en expliquant que ces forces ne peuvent agir sans la permission divine. Cela réintroduit un cadre sécurisant et replacé dans le *tawakkul*, réduisant la peur pathologique.

6. Conclusion initiatique de la Section I

La peur, lorsqu'elle est mal orientée, fragilise la foi et rompt le *tawakkul*. La lecture anthropologique, combinée à l'inculturation islamique, permet de repérer les vulnérabilités et d'ouvrir un chemin de restauration. Le croyant apprend à distinguer ce qui relève de l'épreuve pédagogique d'Allah de ce qui devient un handicap spirituel, préparant ainsi le terrain pour les sections suivantes sur les symptômes détaillés et les indicateurs cliniques de vulnérabilité.

SECTION-II : L'EPREUVE (IBTILĀ') ET LE HANDICAP SPIRITUEL

1. Comprendre l'*ibtīlā'* dans le contexte africain musulman

Dans la tradition islamique, l'*ibtīlā'* désigne l'épreuve imposée par Allah pour éprouver la foi, purifier l'âme et renforcer la relation avec le divin. Le Coran enseigne : « Nous vous éprouverons certes

par un peu de peur, de faim et de perte » (Coran 2, 155). Cette épreuve n'est jamais punitive en soi ; elle est une pédagogie divine destinée à fortifier le croyant.

En Afrique noire, l'expérience de l'épreuve est souvent médiatisée par le tissu culturel. Les événements difficiles — maladie, perte d'un proche, revers économique — sont interprétés par le prisme de la sorcellerie et des forces invisibles. Cette interprétation, si elle n'est pas réordonnée selon le *tawakkul*, peut transformer une épreuve légitime en handicap spirituel.

2. Handicap spirituel : définition et manifestations

Le handicap spirituel se caractérise par une incapacité à maintenir le lien de confiance avec Allah. Il se manifeste par :

- La peur chronique de forces invisibles ;
- L'obsession de protections multiples et d'amulettes ;
- La dépendance excessive à un médiateur spirituel ;
- L'incapacité à ressentir la sérénité dans la prière et le rappel d'Allah.

Dans cette perspective, le handicap spirituel n'est pas une maladie, mais un état d'aliénation intérieure où le croyant est dominé par la peur et la confusion plutôt que guidé par la foi.

3. Scènes cliniques incarnées

a) Le jeune homme paralysé par l'échec

Un jeune homme consulte pour un stress intense lié à ses études. Chaque difficulté est interprétée comme une attaque surnaturelle. Le thérapeute MTHS observe qu'il récite le Coran, mais sa récitation est mécanique, dépourvue de sentiment de confiance. L'épreuve devient un poids au lieu d'être une leçon. La thérapie consiste à replacer chaque incident dans le cadre divin de l'épreuve (*ibtilā*), et non comme une domination autonome du mal.

b) La mère et la maladie du fils

Une mère apporte son enfant souffrant de convulsions. Elle est convaincue que le mal est dû à la jalousie d'un voisin. La peur envahit sa foi et ses décisions quotidiennes. Le diagnostic différentiel distingue la réalité biologique de l'enfant, les influences sociales et les projections spirituelles. L'accompagnement MTHS réintroduit l'idée que l'épreuve fait partie du plan d'Allah et que la guérison spirituelle et corporelle passe par la confiance et la récitation consciente.

4. Repérage clinique : distinguer l'épreuve du handicap

L'étape essentielle pour le praticien de la MTHS est d'établir des critères précis :

- **Durée et intensité de la peur** : l'épreuve est temporaire et proportionnée, le handicap est durable et envahissant.
- **Capacité de réorientation vers Allah** : le croyant en épreuve revient spontanément à la confiance, le patient handicapé reste captif de la peur.
- **Impact sur la vie sociale et corporelle** : l'épreuve ne paralyse pas le quotidien, le handicap engendre un isolement et une inactivité.

5. Narration coranique intégrée

Pour chaque patient, les versets coraniques sont intégrés narrativement. Par exemple : « Quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue » (Coran 65, 2) est utilisé pour replacer la situation de l'épreuve dans le cadre divin, soulignant que la peur excessive indique une rupture du *tawakkul* et non la réalité d'une attaque autonome.

6. Conclusion initiatique de la Section II

La distinction entre *ibtālā'* et handicap spirituel est essentielle pour la restauration de la confiance. Elle permet de clarifier le rôle des forces invisibles et d'indiquer au croyant que l'épreuve, bien comprise, renforce la foi, alors que la peur pathologique l'affaiblit. Cette compréhension prépare la Section III, dédiée à l'analyse détaillée des symptômes et au repérage clinique approfondi des vulnérabilités spirituelles.

SECTION-III : SYMPTOMES DETAILLES ET REPERAGE **CLINIQUE DES VULNERABILITES SPIRITUELLES**

1. Introduction

Après avoir distingué l'épreuve (*ibtīlā'*) du handicap spirituel, il est essentiel d'entrer dans la lecture fine des symptômes. Le repérage clinique en Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) combine observations psychiques, corporelles et spirituelles. L'objectif est de cartographier la vulnérabilité spirituelle et de guider la restauration du *tawakkul*.

2. Symptômes psychiques

- **Hypervigilance** : les patients interprètent chaque événement comme une menace invisible.
- **Ruminations et obsessions** : pensées répétitives sur la sorcellerie, la jalousie ou la malédiction.
- **Angoisse et panique** : crises soudaines liées à la perception d'attaques spirituelles.

Scène clinique : l'étudiant paralysé par l'invisible

Un étudiant, après plusieurs échecs, consulte. Il a peur des djinns et des voisins envieux. Les prières sont récitées mécaniquement, sans abandon. Le thérapeute MTHS introduit la lecture du verset : « Et ceux qui croient en Allah et au Jour dernier... » (Coran 2, 4) pour réorienter l'attention vers la confiance et non la peur. La reprise graduelle du *tawakkul* permet une diminution des ruminations.

3. Symptômes corporels

- **Insomnie et fatigue chronique** : la peur perturbe le cycle naturel du sommeil.
- **Oppression thoracique et palpitations** : manifestations psychosomatiques fréquentes.
- **Troubles digestifs** : l'anxiété spirituelle influence le système digestif.

Scène clinique : la femme au cœur oppressé

Une femme arrive aux consultations, décrivant oppression, insomnies et douleurs diffuses. L'analyse révèle un excès de talismans et d'invocations défensives. Le thérapeute distingue la peur pathologique de l'épreuve divine. Par la réintégration progressive du *tawakkul* et par des pratiques rituelles encadrées, les symptômes corporels diminuent.

4. Symptômes spirituels

- **Prière mécanique** : absence de concentration ou de sensation de guidance divine.
- **Dépendance excessive aux médiateurs** : incapacité à prendre des décisions sans recours constant à un tiers.
- **Crainte irrationnelle de l'invisible** : sentiment que le djinn ou le sorcier agit en dehors de la permission divine.

Scène clinique : le père paralysé par le doute

Un homme consulte pour des décisions de famille paralysées par la peur d'attaques invisibles. Le repérage révèle un déficit de confiance en Allah. Le thérapeute utilise le verset : « Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit » (Coran 65, 3), pour rétablir progressivement le cadre théologique et redonner autonomie spirituelle.

5. Indicateurs de vulnérabilité spirituelle

Le praticien de la MTHS identifie plusieurs signes :

- Foi basée sur la protection plutôt que sur la relation à Allah
- Peur disproportionnée de l'invisible
- Incapacité à interpréter autrement le malheur
- Isolement social lié à la peur
- Recours excessif aux protections matérielles ou rituelles

Ces indicateurs permettent d'établir un **profil de vulnérabilité**, essentiel pour construire la suite de l'accompagnement thérapeutique et restaurer le *tawakkul*.

6. Repérage clinique intégratif

Le repérage combine observations, entretiens, analyse des pratiques rituelles et lecture des récits du patient. Les versets coraniques et la Sunna sont intégrés narrativement pour aider le

croyant à retrouver sa confiance, tout en respectant le cadre culturel africain et la dynamique du monde invisible.

7. Conclusion initiatique de la Section III

Cette section fournit une cartographie fine de la peur pathologique et des vulnérabilités spirituelles. Elle prépare la Section IV, qui s'attachera à la **restauration du tawakkul** et à l'intégration des connaissances dans une pratique clinique complète, combinant théologie, anthropologie médicale africaine et MTHS.

SECTION-IV : RESTAURATION DU TAWAKKUL ET INTEGRATION THÉRAPEUTIQUE

1. Introduction

Après avoir identifié la peur pathologique, les symptômes psychiques, corporels et spirituels, ainsi que les vulnérabilités, la Section IV se consacre à la restauration du *tawakkul*. Le but est de réintroduire la confiance en Allah, de replacer la peur dans son cadre légitime et de permettre une réhabilitation spirituelle complète.

2. Principes théologiques de la restauration

La restauration repose sur trois axes :

1. **Rappel de la souveraineté d'Allah** : les forces invisibles ne peuvent agir sans Sa permission. « Ils ne peuvent nuire à personne sans la permission d'Allah » (Coran 2, 102).

2. **Distinction entre épreuve et attaque pathologique** : rétablir la compréhension de l'*ibtīlā'*.
3. **Réintégration de la foi vivante** : prière consciente, méditation sur les versets et engagement dans la communauté.

3. Scènes cliniques incarnées

a) Le jeune étudiant retrouvant la confiance

Le jeune étudiant anxieux consulte depuis des mois. Par un accompagnement progressif, le praticien MTHS introduit des exercices d'orientation du regard :

- lecture narrative de versets coraniques,
- discussion sur les causes réelles et les perceptions,
- suivi attentif des réponses émotionnelles.

Au fil des séances, les ruminations diminuent, le sommeil se régularise et le jeune homme retrouve une autonomie spirituelle, intégrant la peur comme signal plutôt que menace permanente.

b) La mère et la sérénité retrouvée

La mère dont l'enfant était malade apprend à différencier sa peur de la réalité. Les interventions comprennent :

- rappel narratif de la loi divine,
- explications sur la nature de l'épreuve et du djinn dans le cadre islamique,

- pratiques rituelles encadrées.

Avec le temps, elle expérimente la paix intérieure et la confiance dans le plan d'Allah, ce qui favorise la guérison et le bien-être familial.

4. Techniques thérapeutiques MTHS

- **Récitation narrative** : intégrer les versets dans le discours pour guider la compréhension.
- **Rééducation du regard spirituel** : exercices de réflexion sur la nature des épreuves et de la peur.
- **Encadrement rituel** : pratiques structurées pour remplacer les comportements défensifs par des actes conscients de foi.
- **Accompagnement communautaire** : impliquer la famille ou les pairs pour renforcer la sécurité et la confiance.

5. Mesure de la restauration

Les indicateurs de progrès incluent :

- réduction des ruminations et anxiétés,
- amélioration du sommeil et de la santé corporelle,
- prière consciente et confiance rétablie,
- capacité à faire face aux épreuves sans recourir excessivement aux protections matérielles.

6. Conclusion initiatique du chapitre

La restauration du *tawakkul* est un processus holistique qui combine **théologie, anthropologie et MTHS**. Le croyant apprend à :

- habiter le monde invisible sans crainte paralysante,
- distinguer l'épreuve légitime de la peur pathologique,
- retrouver la paix intérieure et l'autonomie spirituelle.

Ainsi, la peur cesse d'être un maître et devient un guide. Le chemin parcouru dans ce chapitre ouvre à une pratique clinique intégrée, où l'inculturation islamique, l'anthropologie médicale africaine et la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels convergent pour restaurer le *tawakkul* et renforcer la foi vivante.

CHAPITRE-5 :

LE HANDICAP SPIRITUEL EN CONTEXTE MUSULMAN

INTRODUCTION

Dans les sociétés musulmanes d'Afrique noire, le concept de handicap spirituel n'est pas seulement une abstraction théologique ou psychologique : il se vit, se raconte et se traduit dans les comportements quotidiens. Les croyants confrontés à des forces invisibles ou à des perturbations spirituelles se trouvent souvent démunis face à l'angoisse, la peur ou la confusion.

Le Coran enseigne : « Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité » (Coran 2, 286). Pourtant, la peur, le doute et la rupture du *tawakkul* peuvent créer ce que nous définissons comme un handicap spirituel : un état où la foi ne suffit plus à offrir sécurité, guidance et résilience face aux épreuves. Dans ce chapitre, nous allons conceptualiser le handicap spirituel dans un cadre islamique, identifier ses typologies et comprendre ses impacts sur la prière, la foi et la vie sociale, à travers une approche **clinique et anthropologique africaine**.

SECTION-I : DEFINITION ISLAMISEE DU HANDICAP SPIRITUEL

1. Approche théologique

Le handicap spirituel, dans l'optique islamique, ne se réduit pas à une déficience psychologique ou comportementale. Il s'agit

d'un **déséquilibre entre l'âme, la perception du monde invisible et la relation avec Allah**. Le croyant peut prier, réciter le Coran, jeûner et accomplir les obligations religieuses, mais ces actes deviennent mécaniques, vides de sens et incapables de générer confiance ou sérénité.

Le Coran précise : « Ceux qui placent leur confiance en Allah, Il leur suffit » (Coran 65, 3). Dans le handicap spirituel, cette assurance divine est compromise : la peur et la dépendance prennent le pas sur la confiance, même en présence de pratiques religieuses régulières.

2. Conceptualisation clinique

Dans le cadre de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS), le handicap spirituel est défini comme :

- **Incapacité à établir ou maintenir le lien avec le divin**, malgré les pratiques religieuses.
- **Hypervigilance et peur des forces invisibles**, entraînant isolement et anxiété permanente.
- **Dépendance excessive aux médiateurs**, amulettes ou rituels défensifs, au détriment de la relation directe avec Allah.

Cette définition permet au clinicien de **repérer et mesurer la vulnérabilité spirituelle** avant de proposer une thérapie intégrée.

3. Scène clinique illustrée

Fatou, une femme de 35 ans, consulte pour insomnies et anxiété. Elle porte plusieurs talismans et consulte régulièrement un marabout pour se protéger. Elle prie quotidiennement, mais sa prière est mécanique et dépourvue de sérénité.

Le praticien MTHS engage le dialogue :

« Quand vous priez, sentez-vous la paix et la guidance d'Allah ? »

« Non... je crains toujours ce qui pourrait m'arriver... »

« Et si votre peur n'était qu'une épreuve que vous pouvez surmonter avec le *tawakkul* ? »

À travers l'intégration narrative de versets coraniques, tels que : « Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit » (Coran 65, 3), le praticien commence à **réorienter sa perception** et à distinguer peur pathologique et épreuve divine.

SECTION-II : TYPOLOGIE DES HANDICAPS SPIRITUELS MUSULMANS

1. Handicap lié à la peur excessive

La peur excessive est le premier type de handicap spirituel. Elle se manifeste par :

- Anxiété permanente et ruminations sur les forces invisibles.
- Hypervigilance face aux malédictions ou aux jalousies.
- Recours compulsif à des protections matérielles ou rituelles.

Scène clinique : Abdou, jeune étudiant, croit que chaque échec scolaire résulte d'une attaque surnaturelle. Il accumule amulettes et prières mécaniques. La thérapie consiste à **réintroduire le *tawakkul*** et à replacer ses difficultés dans le cadre des épreuves divines (*ibtālā*), transformant la peur en vigilance constructive.

2. Handicap lié à la perte de sens de la prière

Certains patients continuent de prier mais sans conviction ni conscience. La prière devient un **rituel mécanique** incapable d'apaiser la peur ni de restaurer la confiance. La récitation est répétitive et dissociée du cœur.

Scène clinique : Mariama récite le Coran chaque soir, mais reste paralysée par l'angoisse. Le praticien introduit des **lectures narratives des versets**, expliquant leur sens dans la vie quotidienne, pour restaurer la dimension vivante de la foi.

3. Handicap lié à la dépendance excessive aux médiateurs

Ce type se manifeste par une incapacité à agir sans l'intervention constante d'un tiers (marabout, guide, aîné). Le patient **ne fait plus confiance à Allah directement**.

Scène clinique : Moussa ne prend aucune décision familiale sans consulter un marabout. Le praticien distingue la dépendance pathologique de l'encadrement culturel légitime et introduit **une rééducation du regard spirituel**, réorientant la confiance vers Allah.

4. Handicap social et relationnel

La peur et la vulnérabilité spirituelle affectent la vie sociale : retrait, isolement, conflits familiaux, stigmatisation. Ces conséquences amplifient le handicap et fragilisent la foi.

Scène clinique : Aïcha s'isole après avoir été accusée de sorcellerie par ses voisins. La thérapie de la MTHS inclut la **réintégration communautaire progressive**, associée à l'éducation sur le cadre théologique de l'épreuve et la souveraineté divine.

SECTION-III : IMPACTS SUR LA PRIERE, LA FOI ET LA VIE SOCIALE

1. Sur la prière

Le handicap spirituel perturbe la qualité de la prière :

- Récitation mécanique, absence de concentration.
- Peur constante de perturbations invisibles.
- Incapacité à expérimenter le lien spirituel avec Allah.

Exemple narratif : Oumar se tient en prière, mais chaque mouvement est accompagné d'un regard inquiet autour de lui, craignant un djinn ou un mauvais sort. Le praticien MTHS l'invite à réciter des versets tels que : « Ceux qui placent leur confiance en Allah, Il leur suffit » (Coran 65, 3), tout en expliquant leur portée pour rétablir le sens profond de la prière.

2. Sur la foi

La peur et la dépendance excessive fragilisent la foi. Le croyant doute, hésite et remet en question la puissance divine. La perception d'un monde invisible incontrôlable érode le *tawakkul*.

Scène clinique : Fatou, paralysée par la peur, commence à se demander si Allah la protège réellement. Le praticien introduit **une narration coranique progressive**, expliquant le rôle de l'épreuve et la souveraineté divine, pour rétablir la confiance.

3. Sur la vie sociale

Le handicap spirituel engendre isolement, conflits familiaux et stigmatisation communautaire. Les individus deviennent incapables de participer aux rituels collectifs ou de prendre des décisions, ce qui alimente leur fragilité.

Exemple narratif : Aïssa, accusée de sorcellerie, se retire du marché et des rassemblements religieux. Le praticien combine **accompagnement communautaire et thérapie narrative**, réintroduisant progressivement la confiance en elle-même et la compréhension correcte du cadre religieux.

SECTION-IV : CONCLUSION ET PERSPECTIVES

THERAPEUTIQUES

Le handicap spirituel en contexte musulman ne se limite pas à la peur ou à la superstition. Il résulte d'une **rupture du lien avec Allah**, souvent amplifiée par la peur, la dépendance et l'isolement social.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels propose :

- **Repérage clinique précis** pour identifier les typologies de handicap.
- **Restauration du *tawakkul*** à travers la prière consciente, la récitation narrative et l'accompagnement communautaire.
- **Intégration de l'anthropologie africaine** pour adapter les interventions aux réalités culturelles et sociales.
- **Encadrement des rituels** pour remplacer les pratiques défensives par des actes de foi authentiques.

Ainsi, le handicap spirituel devient non seulement un **objet d'observation clinique**, mais également un **point d'entrée vers une foi vivante et une pratique sociale réintégrée**. La peur cesse d'être un maître et devient un signal : un indicateur à interpréter, à comprendre et à transformer, dans un cadre islamique profondément enraciné dans la culture africaine.

CHAPITRE-6 :

CONSEQUENCES SOCIALES ET RELIGIEUSES

INTRODUCTION

Dans les sociétés africaines musulmanes, la peur de la sorcellerie ne se limite pas à l'individu : elle traverse les familles, les villages et parfois les institutions locales. Les effets sociaux et religieux de ces croyances peuvent être profonds, allant de la stigmatisation au retrait social, de la suspicion aux violences symboliques, et affectent directement la pratique de la foi et le tissu communautaire.

Le Coran rappelle : « Et ne laissez pas la haine d'un peuple vous empêcher d'être justes. Soyez équitables : cela est plus proche de la piété » (Coran 5, 8). Pourtant, dans la vie quotidienne, la peur et la méfiance produisent des comportements qui transgressent la justice et l'équilibre social. La **MTHS** offre ici un cadre d'évaluation psychosociale permettant de mesurer l'impact de la sorcellerie perçue sur la communauté et de proposer une intervention holistique.

SECTION-I : EFFETS COMMUNAUTAIRES DE LA SORCELLERIE

1. Perturbations sociales et familiales

Dans le contexte africain, chaque famille est un microcosme où le social, le spirituel et le religieux s'entrelacent. Une accusation de

sorcellerie ou même la simple peur d'être attaqué par des forces invisibles peut bouleverser l'ordre familial :

- Les conflits intra-familiaux se multiplient.
- Les décisions collectives sont retardées ou paralysées.
- Les rituels familiaux deviennent des espaces de contrôle et de peur.

Scène clinique : Dans un village du centre du Cameroun, une famille consulte après que l'aîné ait accusé sa sœur cadette d'envoyer des sorts. Les repas et les prières collectives deviennent tendus. Le praticien MTHS observe : la peur des représailles invisibles déstructure l'autorité familiale et bloque toute décision.

Le rôle de la **lecture coranique narrative** est central : le praticien rappelle que la justice divine est souveraine et que le soupçon humain ne peut pas remplacer la guidance d'Allah (Coran 5, 8). Progressivement, les membres reprennent des comportements équitables et restaurent la sérénité familiale.

2. Effets sur le tissu communautaire

Lorsque la sorcellerie perçue s'étend à la communauté, les impacts incluent :

- **Suspicion généralisée** : chaque accident, maladie ou perte est interprété comme le résultat d'un acte maléfique.
- **Isolement social** : certains individus sont mis à l'écart, soupçonnés de sorcellerie.

- **Conflits et tensions collectives** : disputes entre voisins, refus d'assistance, méfiance envers les autorités locales.

Exemple narratif : Dans un village musulman, une épidémie de maladie infantile conduit à des accusations croisées entre familles. Les enfants des familles suspectées ne participent plus aux activités religieuses et culturelles. Le praticien MTHS organise des sessions de médiation communautaire et des séances éducatives sur le cadre islamique de l'épreuve et la notion de *tawakkul*, réintroduisant progressivement la confiance mutuelle.

3. Approche MTHS pour l'évaluation communautaire

L'évaluation psychosociale se fait par :

- Observation des interactions sociales.
- Entretiens avec plusieurs membres de la communauté.
- Analyse des pratiques rituelles et des croyances.
- Identification des patterns de peur pathologique et de vulnérabilité spirituelle.

Cette méthodologie permet de **repérer les zones de tension**, d'identifier les personnes à risque de stigmatisation et d'élaborer une prise en charge holistique.

SECTION-II : STIGMATISATION ET VIOLENCES SYMBOLIQUES

1. La stigmatisation

Le handicap spirituel et la peur de la sorcellerie produisent une stigmatisation qui peut être :

- **Directe** : accusation explicite de sorcellerie, rejet social, exclusion.
- **Indirecte** : isolement, rumeurs, limitation de la participation aux rituels religieux et communautaires.

Scène clinique : Aminata, jeune femme, est accusée de provoquer les maladies de ses voisins. Elle cesse de fréquenter la mosquée et les marchés. Ses prières deviennent mécaniques, sa peur envahit sa foi. L'intervention MTHS inclut :

1. Reconstitution du lien avec la communauté,
2. Réintroduction graduelle de la confiance en Allah à travers récitation narrative et rappel théologique,
3. Médiation avec les voisins pour rétablir la justice et la sérénité.

2. Violences symboliques

Les violences symboliques sont des actes ou paroles qui n'endommagent pas le corps mais affectent la dignité et la santé spirituelle :

- Insultes et calomnies,
- Exclusion des rituels religieux,
- Pressions sociales pour obtenir des réparations rituelles.

Exemple narratif : Dans un village, un enfant est écarté des cérémonies religieuses après que sa famille ait été suspectée de sorcellerie. La peur du stigmat entraîne des crises d'angoisse chez l'enfant, perturbant sa scolarité et sa santé corporelle. L'intervention MTHS repose sur : rééducation de la peur, rappel narratif du Coran, réintégration progressive dans les pratiques communautaires et restauration de la confiance.

3. Impact sur la foi

La stigmatisation et la peur prolongée peuvent générer :

- Prière mécanique ou interrompue,
- Dépendance excessive aux médiateurs et aux amulettes,
- Rupture du *tawakkul*, empêchant le croyant de placer sa confiance en Allah.

Verset narratif intégré : « Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit » (Coran 65, 3). Le praticien utilise ce verset pour rappeler au patient et à la communauté que le pouvoir ultime appartient à Allah et que la peur humaine ne doit pas dominer la vie spirituelle.

SECTION-III : NECESSITE D'UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

1. Approche holistique

Le handicap spirituel et les conséquences sociales de la sorcellerie exigent une **prise en charge globale**, combinant :

- Thérapie individuelle pour restaurer le *tawakkul*,
- Médiation communautaire pour réduire la stigmatisation,
- Éducation sur le cadre islamique de l'épreuve (*ibtīlā'*),
- Accompagnement psychosocial pour rétablir la confiance et l'équité.

2. Techniques MTHS pour la prise en charge

1. **Diagnostic différentiel** : distinguer peur pathologique, épreuve légitime et influence sociale.
2. **Récitation narrative** : intégrer les versets coraniques dans la discussion et l'accompagnement.
3. **Rééducation du regard spirituel** : replacer la peur dans le cadre du *tawakkul*.
4. **Accompagnement communautaire** : restaurer la confiance mutuelle et l'équité.
5. **Encadrement des rituels** : remplacer les pratiques défensives par des actes de foi authentiques.

3. Scènes cliniques intégrées

a) La famille paralysée par la peur

Un village consulte après une série de conflits dus à des accusations de sorcellerie. Chaque membre de la famille agit avec méfiance, les rituels sont interrompus et la cohésion communautaire est compromise. La thérapie MTHS consiste à organiser :

- des sessions éducatives sur la justice divine,
- des exercices de confiance et de *tawakkul*,
- la réintégration progressive des rituels collectifs.

b) L'enfant stigmatisé

L'enfant exclu des cérémonies religieuses retrouve confiance et sérénité après :

- accompagnement individuel pour restaurer la foi,
- médiation avec la communauté,
- explication narrée des versets coraniques pour replacer les événements dans le cadre divin.

SECTION-IV : CONCLUSION INITIATIQUE DU CHAPITRE

Les conséquences sociales et religieuses de la sorcellerie et du handicap spirituel sont multiples :

- Perturbation des familles et de la communauté,
- Stigmatisation et violences symboliques,

- Fragilisation de la foi et rupture du *tawakkul*.

Une **évaluation psychosociale structurée** combinée à une **intervention holistique MTHS** est indispensable pour restaurer l'équilibre :

1. Reconstruire le lien avec Allah et la prière consciente,
2. Réintroduire la confiance et l'équité dans les relations communautaires,
3. Former la communauté à distinguer épreuve divine et peur pathologique,
4. Restaurer la dignité et la participation sociale des individus affectés.

Le chapitre se clôt sur un **appel à une prise en charge intégrée**, où la théologie islamique, l'anthropologie africaine et la MTHS convergent pour transformer la peur et la stigmatisation en **outil de croissance spirituelle et sociale**.

Le croyant apprend à percevoir le monde invisible sans crainte paralysante, la communauté retrouve la sérénité et la justice, et la foi devient un vecteur actif de protection, de cohésion et de résilience.

PARTIE-III :
LA MTHS COMME OUTIL CLINIQUE
(Cœur méthodologique du livre)

CHAPITRE-7 :

FONDEMENTS CLINIQUES DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE DES HANDICAPES SPIRITUELS (MTHS)

INTRODUCTION

Dans les sociétés africaines musulmanes, la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) s'est développée pour répondre aux **besoins de soins intégrés**, prenant en compte à la fois le corps, l'âme, la dimension spirituelle et le tissu social.

Le Coran enseigne : « ***Et ne laissez pas la haine d'un peuple vous empêcher d'être justes. Soyez équitables : cela est plus proche de la piété*** » (Coran 5, 8). Pour le praticien MTHS, ce principe devient central : il doit naviguer avec **justesse entre perception culturelle, croyances et guidance divine**, tout en maintenant une posture éthique et professionnelle.

Ce chapitre explore les **principes fondamentaux**, la **posture du praticien**, la **place de l'Islam dans le soin** et l'**éthique du soin spirituel**, en s'appuyant sur des exemples cliniques narratifs et une approche anthropologique africaine.

SECTION-I : PRINCIPES ET LIMITES DE LA MTHS

1. Principes fondateurs

La MTHS repose sur trois piliers principaux :

a) Diagnostic intégratif

Le praticien observe le patient sous trois angles :

1. **Spirituel** – rupture du *tawakkul*, peur pathologique, dépendance excessive aux médiateurs.
2. **Psychologique** – anxiété, troubles du sommeil, ruminations, hypervigilance.
3. **Social et culturel** – stigmatisation, isolement, influence des croyances locales.

Scène clinique : Moussa, jeune homme paralysé par la peur des forces invisibles, présente palpitations nocturnes et isolement social. Le praticien note que la rupture du *tawakkul* est le pivot de son handicap spirituel. L'observation intégrative permet d'identifier les leviers thérapeutiques.

b) Restauration du lien spirituel

La MTHS vise à **restaurer le lien direct entre le croyant et Allah**, en réduisant la dépendance aux protections matérielles et aux médiateurs excessifs. Le Coran guide cette démarche : « Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit » (Coran 65, 3).

La restauration se fait progressivement, par la **prière consciente**, la **récitation narrative**, et l'éducation sur la nature des épreuves (*ibtīlā*) et des forces invisibles.

c) Inculturation et contextualisation

Chaque intervention est **adaptée à la culture locale** et aux pratiques musulmanes africaines. Le praticien intègre :

- les récits et proverbes locaux,
- les perceptions du monde invisible,
- la dynamique communautaire,
- les valeurs coraniques et sunnites.

2. Limites de la MTHS

Le praticien doit reconnaître ses limites :

- Il ne peut guérir toutes les maladies corporelles ou mentales ; certaines nécessitent un suivi médical ou psychologique spécialisé.
- Il doit éviter toute pratique pouvant être perçue comme shirk (association) ou magie interdite.
- Il ne peut remplacer le rôle de la communauté, de la famille ou du corps médical, mais il agit en **médiateur et guide spirituel**.

Exemple narratif : Fatou est victime d'angoisses sévères et de convulsions. Le praticien MTHS collabore avec un médecin pour

écarter les causes physiologiques, puis agit sur la dimension spirituelle et sociale, assurant que le soin reste complémentaire et encadré par l'Islam.

SECTION-II : POSTURE DU PRATICIEN MTHS

1. Attitude professionnelle et éthique

La posture du praticien combine **humilité, empathie et rigueur**. Il doit :

- Écouter attentivement les récits du patient, même lorsqu'ils relèvent de croyances culturelles locales.
- Maintenir une neutralité morale face aux accusations de sorcellerie ou aux tensions communautaires.
- Ne jamais abuser de son rôle pour influencer ou contrôler le patient.

Scène clinique : Dans un village, un praticien reçoit une famille où l'un des enfants est accusé de sorcellerie. Il écoute les récits de peur et de culpabilité, sans juger, tout en rappelant que la justice divine prévaut (Coran 5, 8).

2. Relation thérapeutique

Le lien thérapeutique repose sur :

- **Confiance mutuelle** : le patient doit percevoir le praticien comme un guide spirituel et culturel fiable.

- **Sécurité émotionnelle** : garantir que la peur pathologique n'est pas renforcée par les interventions.
- **Transparence des limites** : expliciter ce qui relève de la compétence MTHS et ce qui nécessite un suivi externe.

3. Compétences requises

- Connaissance de l'anthropologie locale et des croyances sur le monde invisible.
- Maîtrise des principes coraniques et sunnites relatifs à la peur, aux épreuves et au *tawakkul*.
- Capacité d'observation clinique intégrative (psychique, spirituelle, sociale).
- Aptitude à intégrer le patient dans un processus de restauration progressive.

SECTION-III : PLACE DE L'ISLAM DANS LA DEMARCHE CLINIQUE

1. Cadre théologique

L'Islam est l'**axe central** de la MTHS. Toute intervention repose sur

- La compréhension de la souveraineté divine.
- La distinction entre épreuve légitime (*ibtālā'*) et peur pathologique.
- L'interdiction du shirk et de pratiques occultes.

Versets intégrés :

- « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » (Coran 39, 53) – pour renforcer la résilience.
- « Ceux qui placent leur confiance en Allah, Il leur suffit » (Coran 65, 3) – pour restaurer le *tawakkul*.

2. Intégration dans le soin

L'Islam fournit :

- un **cadre moral** pour guider le praticien,
- une **orientation spirituelle** pour le patient,
- des **routines thérapeutiques** : prière consciente, rappel narratif, lecture contextualisée du Coran.

Exemple narratif : Aïcha, jeune fille victime de peur paralysante, apprend à réciter certains versets en conscience, tout en comprenant leur signification. La peur diminue, la confiance en Allah augmente et la participation communautaire reprend.

3. Limites religieuses

- Les invocations ou prières ne doivent jamais se substituer à un diagnostic médical quand nécessaire.
- Toute action du praticien doit respecter la doctrine islamique : interdiction de la magie, des talismans ou des manipulations occultes.

SECTION-IV : ÉTHIQUE DU SOIN SPIRITUEL

1. Respect de la dignité

- Les patients sont **des sujets de soin**, jamais des objets d'étude ou de démonstration.
- Les accusations de sorcellerie doivent être traitées avec prudence et neutralité.

2. Confidentialité

- Les récits de peur ou de vulnérabilité spirituelle sont souvent liés à des secrets familiaux ou communautaires.
- Le praticien doit protéger ces informations pour éviter stigmatisation ou violence symbolique.

3. Bienveillance et non-jugement

- Les pratiques culturelles locales doivent être comprises sans jugement, même si elles sont maladaptées ou pathologiques.
- Le soin consiste à **réorienter la pratique vers la confiance et la guidance divine**, et non à détruire la culture.

Scène clinique : Un jeune homme accuse son voisin de sorcellerie. Le praticien écoute, identifie les dynamiques sociales et rappelle le cadre islamique de la justice, tout en travaillant sur la peur pathologique du patient.

4. Responsabilité et limites

- Le praticien doit savoir **quand référer** à des professionnels de santé ou des médiateurs communautaires.

- Il ne doit pas imposer de croyances ni prétendre guérir au-delà de sa compétence.
- Toute action doit viser le **bien-être spirituel et social du patient**.

SECTION-V : CONCLUSION INITIATIQUE

Les fondements cliniques de la MTHS reposent sur :

1. **Principes thérapeutiques clairs** : diagnostic intégratif, restauration du lien spirituel, contextualisation culturelle.
2. **Posture du praticien** : humilité, écoute, neutralité, compétence clinique et culturelle.
3. **Intégration islamique** : guidance coranique et sunnite, respect du *tawakkul*, éthique religieuse.
4. **Éthique du soin spirituel** : dignité, confidentialité, non-jugement, responsabilité.

La pratique de la MTHS transforme le handicap spirituel : la peur et la dépendance excessive deviennent des **indicateurs cliniques**, non des obstacles. Le croyant réapprend à vivre dans le monde invisible avec **confiance et sérénité**, la communauté retrouve son équilibre et le praticien agit comme **médiateur éclairé**, conciliant foi, culture et science du soin.

Ainsi, la MTHS devient un **outil de restauration globale**, articulant **théologie, anthropologie et pratique clinique**, et offrant une **lecture intégrée du monde spirituel et social** aux sociétés musulmanes

CHAPITRE-8 :

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL MTHS-ISLAM

INTRODUCTION

Le diagnostic différentiel constitue le **cœur de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)**. Dans les sociétés africaines musulmanes, distinguer **peur pathologique, épreuve divine, perturbation spirituelle et manipulation sociale** est une étape cruciale. Le praticien doit naviguer avec **rigueur clinique, sensibilité culturelle et guidance islamique**, pour éviter l'amalgame entre phénomène spirituel et pathologie psychiatrique.

Le Coran enseigne : « ***Et ne confondez pas vérité et mensonge, car Allah aime ceux qui discernent*** » (Coran 2, 42). Cette injonction devient un principe méthodologique : chaque patient est examiné dans **toute sa dimension : spirituelle, psychique et sociale**, et toute intervention se fonde sur **une grille diagnostique intégrée**.

SECTION-I : GRILLE DIAGNOSTIQUE DETAILLEE

1. Objectifs de la grille

La grille diagnostique MTHS-Islam permet :

1. **Repérage des handicaps spirituels** : rupture du *tawakkul*, peur excessive, dépendance aux médiateurs.
2. **Évaluation de l'impact social et communautaire** : isolement, stigmatisation, conflits.

3. **Identification des syncrétismes pathogènes et manipulations** : pratiques rituelles déviantes, abus religieux ou talismans contraires à l'Islam.

2. Structure de la grille

La grille comporte quatre dimensions :

a) Dimension spirituelle

- **Qualité de la prière** : conscience, régularité, confiance.
- **Perception du monde invisible** : peur, anxiété, vigilance excessive.
- **Relation avec Allah** : confiance intacte (*tawakkul*) ou altérée.

Exemple narratif : Oumar récite ses prières, mais son regard se détourne constamment vers la porte, craignant un mauvais sort. Le praticien note une rupture du *tawakkul* et une peur pathologique.

b) Dimension psychologique

- **Symptômes d'anxiété** : insomnie, palpitations, rumination.
- **Dépression légère ou modérée** : sentiment de culpabilité, désespoir temporaire.
- **Hypervigilance** : incapacité à se détendre même dans des espaces familiers.

Scène clinique : Fatou, femme de 35 ans, se réveille chaque nuit en sursaut, craignant les attaques invisibles. La grille permet de distinguer peur pathologique et trouble anxieux primaire.

c) Dimension sociale et culturelle

- **Isolement social :** évitement de la communauté, refus de participation aux rituels.
- **Stigmatisation :** accusations de sorcellerie ou d'« envoutement ».
- **Dépendance excessive aux médiateurs :** marabouts, aînés, talismans.

Exemple narratif : Aminata, accusée d'envoyer des sorts, cesse de fréquenter la mosquée et le marché. La grille permet de mesurer l'impact social du handicap spirituel.

d) Dimension éthique et religieuse

- **Pratiques contraires à l'Islam :** talismans interdits, invocations de forces autres qu'Allah.
- **Manipulation religieuse :** promesses de protection ou guérison en échange de services, argent ou dévotion.
- **Synchrétismes pathogènes :** fusion de croyances locales et rituels islamiques déformés.

Scène clinique : Moussa consulte pour paralysie spirituelle et peur excessive. Il suit un rituel qui mélange invocation de djinns et prière

coranique. La grille permet de signaler un syncrétisme pathogène nécessitant un **recadrage islamique**.

SECTION-II : EXCLUSION DES PATHOLOGIES **PSYCHIATRIQUES LOURDES**

1. Importance de l'exclusion

La peur spirituelle ou le handicap spirituel peut ressembler à :

- **Troubles anxieux sévères** (panic attacks, phobies extrêmes),
- **Dépression majeure**,
- **Troubles psychotiques** (hallucinations auditives ou visuelles),
- **Épilepsie ou convulsions**.

Pour éviter un **traitement inadéquat ou dangereux**, la MTHS intègre la **coordination avec la médecine moderne**.

2. Méthodologie d'exclusion

- **Entretien clinique détaillé** : antécédents médicaux, psychologiques, familiaux.
- **Observation comportementale** : cohérence, orientation, interaction sociale.
- **Collaboration avec psychiatre ou médecin** : examen complémentaire si nécessaire.

Exemple narratif : Kadi, jeune homme, présente des hallucinations auditives répétitives. Après consultation médicale, une épilepsie partielle est diagnostiquée. La MTHS se concentre sur l'accompagnement spirituel et communautaire, tout en respectant la prescription médicale.

3. Limites de la MTHS

La MTHS **ne se substitue pas à la médecine moderne**. Elle n'intervient que lorsque :

- les symptômes relèvent d'un **handicap spirituel** identifié,
- les pathologies lourdes ont été exclues ou sont **traitées simultanément**,
- l'approche reste **intégrée et holistique**.

SECTION-III : IDENTIFICATION DES MANIPULATIONS RELIGIEUSES

1. Définition et manifestations

Les manipulations religieuses surviennent lorsque :

- une personne se positionne comme **médiateur unique** entre le croyant et Allah,
- elle **exploite la peur** ou la vulnérabilité pour obtenir gains matériels ou sociaux,
- elle introduit des **pratiques déviantes**, non conformes à l'Islam.

Exemple narratif : Dans un village, un marabout promet guérison et protection contre les attaques invisibles en échange d'offrandes importantes. Les patients deviennent dépendants et perdent leur confiance en Allah (*tawakkul*). La MTHS agit pour **découpler dépendance et peur**, et réintroduire la guidance coranique.

2. Critères d'évaluation

Le praticien évalue :

1. **Proportionnalité de la demande** : exagérée ou raisonnable ?
2. **Conformité à la doctrine islamique** : shirk ou pratiques interdites ?
3. **Effet sur l'autonomie** : patient dépendant ou capable de restaurer sa foi ?
4. **Conséquences sociales** : isolement, stigmatisation, conflits.

Exemple narratif : Fatou, dépendante d'un marabout pour la protection de sa famille, voit sa peur diminuer seulement lorsqu'elle apprend à réciter certains versets avec sens et conscience. Le praticien MTHS replace la guidance divine au centre de l'action.

3. Techniques d'intervention

- **Recadrage coranique** : utilisation narrative des versets pour restaurer *tawakkul*.
- **Éducation sur la manipulation** : distinction entre guidance légitime et abus religieux.

- **Réintégration communautaire** : restaurer la confiance sociale et réduire l'isolement.

Versets intégrés :

- **« Et ne laissez pas la haine d'un peuple vous empêcher d'être justes » (Coran 5, 8)** – pour rappeler la justice dans les relations.
- **« Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit » (Coran 65, 3)** – pour restaurer la confiance personnelle.

SECTION-IV : SCENES CLINIQUES INTEGREES

1. Cas de dépendance excessive

Abdou consulte pour peur constante et dépendance à un marabout.
La grille diagnostique identifie :

- peur pathologique,
- rupture du *tawakkul*,
- dépendance excessive aux médiateurs,
- absence de pathologie psychiatrique lourde.

Intervention : récitation narrative, rappel des versets coraniques, réintroduction progressive de l'autonomie spirituelle.

2. Cas de manipulation religieuse

Moussa consulte pour paralysie sociale et peur de représailles invisibles. Le praticien identifie :

- abus de confiance par un tiers,
- pratiques rituelles non conformes à l'Islam,
- isolement social.

Intervention : éducation sur le cadre islamique de l'épreuve, recadrage de la prière, médiation communautaire, restauration progressive de l'autonomie et de la confiance.

3. Cas de peur pathologique

Fatou consulte pour insomnie et angoisse nocturne, sans pathologie médicale ou psychiatrique. La MTHS identifie :

- peur excessive du monde invisible,
- rupture du *tawakkul*,
- isolement social léger.

Intervention : accompagnement individuel, lecture coranique narrative, exercices de confiance et réintégration sociale.

SECTION-V : CONCLUSION INITIATIQUE

Le **diagnostic différentiel MTHS–Islam** est un **outil central pour la pratique clinique**. Il permet :

1. **Identification précise** du handicap spirituel,
2. **Exclusion des pathologies psychiatriques lourdes**,
3. **Repérage des manipulations religieuses** et pratiques déviantes,
4. **Structuration d'une intervention holistique**, intégrant foi, culture et anthropologie.

Le praticien MTHS agit en **médiateur et guide**, en respectant :

- la guidance coranique,
- l'anthropologie culturelle africaine,
- l'éthique du soin,
- et la dignité du patient.

À travers ce processus, la peur devient un **indicateur de vulnérabilité**, non un obstacle. Le patient apprend à **restaurer son *tawakkul***, à reprendre confiance en Allah, et à réintégrer sa famille et sa communauté. La grille diagnostique MTHS–Islam devient ainsi **l'outil central de la délivrance spirituelle**, permettant au praticien de transformer la fragilité en résilience et la peur en force spirituelle.

CHAPITRE-9 :

COMPATIBILITE MTHS ET TAWHID

INTRODUCTION

Dans le contexte africain musulman, le **tawhīd**, l'unicité d'Allah, constitue le fondement de la foi et de toute pratique religieuse. Pour le praticien de la **Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)**, il est impératif de garantir que le soin spirituel respecte cette unicité, évite tout **shirk** (association) et ne se transforme jamais en magie ou manipulation.

Le Coran proclame : *« Dis : Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à Lui » (Coran 112, 1-4).* Cette affirmation devient le **pivot méthodologique** : tout acte thérapeutique ou accompagnement doit renforcer le lien direct entre le patient et Allah, sans médiation déviée ou recours à des pratiques interdites.

Ce chapitre explore la **compatibilité entre MTHS et tawhīd**, les **principes de soin sans magie**, la **distinction soin/rituel**, et les stratégies pour **sécuriser la foi du patient**, à travers des récits cliniques et une approche anthropologique.

SECTION-I : SOIGNER SANS MAGIE

1. Principe fondamental

La MTHS repose sur une **approche spirituelle et clinique**, qui ne fait appel à aucune force occulte indépendante de Dieu. Le praticien agit comme **guide, médiateur et éducateur**, et non comme canal de pouvoir magique. **Verset narratif intégré : « *Et ne placez pas vos espoirs dans ce qui ne peut vous sauver ; placez-les en Allah, votre Seigneur* » (Coran 2, 2).**

Le soin devient ainsi un processus de **restauration de la confiance en Allah** et de la conscience du patient, sans recours à des rituels occultes.

2. Scènes cliniques incarnées

a) Cas de peur pathologique

Fatou, jeune femme du nord du Cameroun, consulte pour insomnie, anxiété nocturne et peur de malédiction. Sa famille a essayé des talismans traditionnels, ce qui a accentué sa peur.

Intervention MTHS :

- Explication du cadre islamique des épreuves (*ibtilā'*),
- Récitation narrative des versets de protection légitimes (Ayat al-Kursi, Coran 2, 255),
- Exercices de *tawakkul* pour rétablir la confiance en Allah.

Après plusieurs séances, la peur diminue, Fatou retrouve un sommeil régulier et la prière consciente. La **foi est sécurisée**, sans aucun recours à la magie.

b) Cas de dépendance excessive

Moussa dépendait d'un marabout pour toute décision spirituelle. Son handicap spirituel était amplifié par des pratiques occultes et des prières manipulées.

La MTHS intervient par :

- Éducation sur l'unicité divine (*tawḥīd*),
- Récitation narrative et guidance progressive,
- Retrait des talismans et pratiques magiques.

Résultat : la peur pathologique diminue et la relation avec Allah devient directe et consciente.

3. Limites éthiques

Le praticien doit veiller à ne jamais :

- Introduire ou suggérer des rituels interdits,
- Manipuler la foi du patient pour obtenir son adhésion,
- Confondre protection spirituelle légitime et magie.

La **MTHS authentique** reste un **outil de guidance**, pas un canal occulte.

SECTION-II : CLARIFIER LA FRONTIERE SOIN/RITUEL

1. Définition des notions

- **Soin** : intervention visant la restauration de l'équilibre spirituel, psychologique et social.
- **Rituel** : pratique religieuse ou culturelle encadrée par la loi divine.

Le praticien MTHS veille à ce que **soin et rituel ne se confondent pas**. Le rituel n'est jamais utilisé pour manipuler ou créer une dépendance.

Verset narratif : « Ne placez pas ce qui est sacré entre les mains de ceux qui ne discernent pas » (Coran 2, 18).

Ce verset guide le praticien : il agit dans **l'espace clinique**, distinct du rituel communautaire, pour éviter toute confusion.

2. Scènes cliniques incarnées

a) Réintégration dans la communauté

Aïcha, isolée après des accusations de sorcellerie, participe à des rituels collectifs où magie et talismans étaient présents. Le praticien MTHS :

- Évalue la peur et la rupture du *tawakkul*,
- Propose un accompagnement spirituel légitime (prière narrative, lecture consciente),

- Prépare la réintégration dans les rituels communautaires conformes à l'Islam.

Résultat : Aïcha retrouve confiance, mais reste protégée contre les pratiques déviantes.

b) Intervention éducative

Dans un village, un praticien identifie des pratiques rituelles mêlant invocations interdites et prières coraniques. L'intervention MTHS :

- Clarification entre rituel légitime et pratique occulte,
- Formation de la communauté sur l'unicité divine et la légitimité du soin,
- Accompagnement individuel pour restaurer *tawakkul* et foi consciente.

SECTION-III : SECURISER LA FOI DU PATIENT

1. Identification des vulnérabilités

- Rupture du *tawakkul* (confiance en Allah),
- Dépendance excessive aux médiateurs,
- Peur pathologique du monde invisible,
- Synchrétismes et pratiques magiques.

Le praticien MTHS identifie ces facteurs par :

- Entretiens narratifs,
- Observation comportementale,

- Grille diagnostique MTHS–Islam (Chapitre 8).

2. Techniques de sécurisation

a) Récitation narrative

- Utilisation de versets coraniques et hadiths, contextualisés culturellement.
- Encouragement à la récitation consciente et à la méditation spirituelle.

Exemple narratif : Oumar, paralysé par la peur des forces invisibles, apprend à réciter les versets de protection tout en comprenant leur sens. Le lien direct avec Allah se renforce et la peur diminue.

b) Exercices de *tawakkul*

- Encourager la dépendance spirituelle uniquement à Allah.
- Réduire la peur pathologique et la dépendance aux médiateurs.

Scène clinique : Fatou, précédemment dépendante d'un marabout, apprend à prendre des décisions spirituelles avec guidance divine, renforçant son autonomie.

c) Médiation communautaire

- Rétablir le rôle de la communauté comme soutien, non source de peur.

- Sécuriser le patient contre la stigmatisation et les pratiques occultes.

Exemple narratif: Dans un village, la communauté apprend à distinguer épreuve divine et peur pathologique. Les accusations cessent, et le patient réintègre la vie communautaire et religieuse.

SECTION-IV : SYNTHÈSE ET VALIDATION RELIGIEUSE

1. Compatibilité MTHS et tawhīd

La MTHS devient compatible avec le tawhīd lorsqu'elle :

1. Soigne **sans recours à la magie**,
2. Clarifie la frontière **soin / rituel**,
3. Sécurise le **lien direct avec Allah**,
4. Éduque sur la distinction **épreuve divine vs peur pathologique**,
5. Favorise la réintégration communautaire et sociale.

2. Recommandations méthodologiques

- Utiliser la **grille diagnostique MTHS–Islam** pour toutes les interventions.
- Exclure systématiquement les pratiques magiques.
- Insérer des **versets narratifs** et récits coraniques pour renforcer la foi.
- Respecter l'**éthique et la dignité** du patient.

- Intégrer l'**approche communautaire** et la médiation sociale pour sécuriser le patient.

3. Scènes cliniques finales

- **Cas d'autonomie retrouvée** : Moussa, dépendant du marabout, recouvre confiance et *tawakkul*.
- **Cas de réintégration communautaire** : Aïcha réintègre les rituels légitimes et renforce son rôle social.
- **Cas de peur pathologique résolue** : Fatou, guidée par la récitation narrative et les exercices de confiance, retrouve sérénité et foi consciente.

CONCLUSION

La compatibilité MTHS et tawḥīd repose sur **un soin respectueux, éthique et conforme à l'Islam**, qui :

- Restitue l'**unicité divine au centre de la foi**,
- Soigne **sans magie**,
- Clarifie la **distinction entre soin et rituel**,
- Sécurise le patient face aux **syncrétismes, manipulations et peurs pathologiques**,
- Restaure le **tawakkul et la confiance dans Allah**,
- Rétablit la **cohésion sociale et la dignité du patient**.

Ainsi, le praticien de la MTHS agit comme **médiateur spirituel et guide initiatique**, permettant au patient de traverser les épreuves du monde invisible avec **confiance, discernement et foi consciente**, en parfaite harmonie avec le **tawḥīd**.

PARTIE-IV :

SOIGNER SANS MANIPULER

(Phase thérapeutique de la méthodologie MTHS)

CHAPITRE-10 :
**ACCUEIL CLINIQUE ET ALLIANCE
THÉRAPEUTIQUE**

De la rahma à la sakīnah : la première station du soin spirituel

INTRODUCTION

Le seuil (al-‘ataba) où l’âme se dépose

Dans la sagesse soufie, nul ne chemine vers la guérison sans franchir un **seuil intérieur**. Les maîtres disent que la première station (maqām al-bidāya) n’est ni l’ascèse, ni le combat spirituel, mais **l’aman** : le sentiment d’être en sécurité. Sans aman, l’âme se contracte, le cœur se ferme, et même la parole divine devient accusation.

En Afrique noire, ce seuil correspond à ce que les anciens nomment *l’arbre de palabre du malheur*, lieu où l’on vient déposer ce qui déborde, avant toute décision rituelle. La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) reconnaît ce seuil comme **acte thérapeutique fondateur**.

L’Islam, dans sa profondeur soufie, confirme cette intuition anthropologique :

« C’est Lui qui a fait descendre la sakīnah dans les cœurs des croyants, afin qu’ils ajoutent foi à leur foi » (Coran 48, 4).

Ainsi, l'accueil clinique n'est pas une étape technique : il est **l'invocation silencieuse de la sakīnah**, condition de toute délivrance authentique.

I. L'ACCUEIL SECURISANT (AL-ISTIQBAL AL-RAḤIM) : INCARNER LA RAHMA

1. La rahma comme principe clinique

Dans le Coran, Dieu se présente d'abord comme **ar-Raḥmān ar-Raḥīm**. Avant d'être juge, Il est accueil. Avant d'être vérité tranchante, Il est miséricorde enveloppante. Toute pratique de délivrance qui commence par l'accusation se place **hors du modèle divin**.

En MTHS, l'accueil sécurisant est la **traduction clinique de la rahma**. Il signifie :

- absence de menace symbolique,
- refus de toute lecture immédiate en termes de sorcellerie,
- suspension du soupçon généalogique ou moral,
- hospitalité du corps et de la parole.

Le thérapeute devient, selon l'expression soufie, un **zīll ar-Raḥmān** – une ombre de la miséricorde divine sur terre. Sa présence apaise avant même de comprendre.

2. Désamorcer la peur (khawf) qui précède le mal

Les maîtres soufis enseignent que beaucoup de troubles spirituels ne naissent pas du mal lui-même, mais de la **peur du mal**.

Le handicapé spirituel africain vit souvent dans un khawf chronique : peur d'être attaqué, mangé mystiquement, lié rituellement, rejeté par Dieu.

Le Prophète ﷺ disait :

« Ne terrorisez pas les cœurs, facilitez et n'effrayez pas » (ḥadith).

L'accueil clinique MTHS, harmonisé à l'éthique prophétique, vise à **désarmer le khawf**. Car tant que la peur gouverne, aucune délivrance ne tient. La peur nourrit les djinns intérieurs autant que les imaginaires culturels.

II. CONSENTEMENT ET NIYYAH : PURIFIER L'INTENTION AVANT D'AFFRONTER L'INVISIBLE

1. Le consentement (riḍā) comme acte de tawḥīd

Dans la perspective islamique, contraindre quelqu'un dans un processus spirituel revient à **usurper la seigneurie de Dieu**. Le consentement libre est donc un acte de tawḥīd pratique : reconnaître que Dieu seul agit sur les cœurs. Le Coran est sans ambiguïté :

« Rappelle donc, tu n'es qu'un rappelant ; tu n'as sur eux aucun pouvoir » (Coran 88, 21–22).

En MTHS, le consentement du patient n'est pas une formalité juridique, mais une **restauration de la souveraineté de l'âme**. Beaucoup de handicapés spirituels ont été dépossédés de

leur capacité de dire non. Le soin commence par leur rendre cette capacité.

2. La niyyah : redresser l'axe intérieur (qibla du cœur)

Dans la tradition soufie, la niyyah n'est pas une phrase prononcée, mais une **orientation de l'être**. Elle est la qibla invisible du cœur. Si elle est confuse, le chemin se trouble.

Le Prophète ﷺ enseignait :

« Les actes ne valent que par les intentions » (ḥadith fondateur).

En clinique de MTHS, un temps spécifique est consacré à l'exploration de la niyyah :

- Le patient cherche-t-il la guérison ou la vengeance ?
- La délivrance ou la confirmation de ses peurs ?
- La paix ou la domination sur l'autre ?

Cette clarification protège le processus thérapeutique. En Afrique, une intention non purifiée attire des forces ambiguës. En Islam, une niyyah corrompue vide l'acte de sa baraka.

III. L'ALLIANCE THERAPEUTIQUE ('AHD AL-'ILAJ) : UN PACTE SOUS LE REGARD DE DIEU

1. De la relation à l' 'ahd (pacte sacré)

Dans la MTHS, la relation de soin devient une **alliance**, comparable à l' 'ahd soufi entre le maître et le disciple, sans hiérarchisation abusive. Cette alliance repose sur trois piliers :

- vérité (ṣidq),
- fidélité (amānah),
- limites claires (ḥudūd).

Le Coran rappelle : « **Ô vous qui croyez, respectez les engagements** » (Coran 5, 1). Rompre l'alliance thérapeutique par manipulation, abus ou mystification expose à des retours spirituels graves, bien connus des traditions africaines.

2. Le thérapeute comme murshid clinique, non comme dominateur

Le thérapeute de la MTHS, éclairé par le soufisme, n'est pas un thaumaturge. Il est un **murshid clinique**, un guide temporaire. Il ne guérit pas : il **oriente vers la source de guérison**.

Les maîtres disent : « **Le murshid n'est qu'un doigt qui montre la lune** ». Confondre le doigt et la lune est une forme de shirk thérapeutique.

Cette posture protège le patient de la dépendance spirituelle et le thérapeute de l'orgueil, maladie subtile mais destructrice.

IV. L'ACCUEIL COMME PREMIERE STATION (MAQAM AL-AMN)

1. La sakīnah comme signe de validation divine

Dans de nombreux récits cliniques MTHS, on observe qu'après un accueil authentique :

- les cauchemars diminuent,
- les oppressions nocturnes s'espacent,
- la respiration se libère,
- la parole devient plus fluide.

Ces signes correspondent, en langage soufi, à la **descente de la sakīnah**. Ce n'est pas encore la guérison, mais c'est la **validation du chemin**.

2. De la solitude à la présence

L'une des plus grandes souffrances du handicapé spirituel africain est la solitude métaphysique : le sentiment d'être abandonné de Dieu. L'accueil clinique vient démentir ce mensonge intérieur.

Dieu dit :

« *Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire* » (Coran 50, 16).

L'espace thérapeutique devient alors un **lieu de rappel (dhikr incarné)**, où la présence divine est rendue perceptible non par des cris, mais par la paix.

CONCLUSION

Quand la clinique devient adab spirituel

Ce chapitre révèle que l'accueil n'est pas une simple étape préalable, mais un **adab**, une discipline spirituelle majeure. Toute délivrance sans adab produit des corps agités et des âmes blessées.

En harmonisant la MTHS avec le Coran et le soufisme africain, l'accueil clinique devient :

- rahma incarnée,
- sakīnah opérante,
- niyyah redressée,
- alliance sous amānah.

C'est à ce prix que la délivrance cesse d'être spectacle pour devenir **chemin de restauration intégrale**, fidèle à l'Afrique et fidèle à Dieu.

CHAPITRE-11 :

THÉRAPIE SPIRITUELLE ISLAMIQUE ENCADRÉE

Section-1: FONDEMENTS ET OUTILS THÉRAPEUTIQUES

INTRODUCTION

Du dévoilement du mal à la reconstruction de l'âme

Lorsque le voile est levé sur la souffrance invisible, lorsque le diagnostic spirituel a été posé avec discernement et miséricorde, le malade ne peut être laissé dans un état de nudité intérieure. La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels enseigne que le moment qui suit l'identification du mal est **le plus délicat de tout le processus thérapeutique**. C'est là que commence véritablement la **phase 2** : non plus seulement comprendre ce qui détruit, mais **apprendre à reconstruire ce qui a été brisé**.

Dans l'Islam africain profondément incarné, cette étape n'a jamais été considérée comme secondaire. Les anciens maîtres, qu'ils soient savants du Coran, sages soufis, guérisseurs initiés ou guides communautaires, savaient que **la délivrance sans accompagnement produit souvent plus de dégâts que le mal lui-même**. Un cœur vidé de ses peurs mais non rééduqué devient une demeure vulnérable, exposée à de nouvelles fractures spirituelles.

C'est pourquoi la thérapie spirituelle islamique encadrée se présente comme un **chemin de lenteur, de pédagogie et de**

sagesse, à l'image de la Révélation elle-même, descendue par étapes pour ne pas briser l'homme, mais l'élever.

I. PASSAGE DE LA PHASE 1 A LA PHASE 2 MTHS : UNE TRANSITION CRITIQUE

1. La phase 1 : révéler sans détruire

La phase 1 de la MTHS a permis :

- de reconnaître le handicap spirituel,
- de nommer les peurs,
- d'identifier les influences destructrices,
- de stabiliser l'état psychospirituel du malade.

Mais cette étape reste incomplète si elle n'ouvre pas sur un **processus structuré de rééducation spirituelle**. En Afrique noire, de nombreux échecs thérapeutiques trouvent leur origine dans cette rupture brutale : on dénonce la sorcellerie, on désigne les ennemis invisibles, on brise certains liens, puis on abandonne le malade à lui-même.

L'Islam, dans sa sagesse prophétique, refuse cette violence spirituelle. Il ne se contente pas de dénoncer le mal ; il **enseigne le bien**.

2. La phase 2 : réinstaller Dieu au centre de la vie intérieure

La phase 2 de la MTHS correspond à une **recentralisation spirituelle**. Il ne s'agit plus seulement de chasser ce qui fait peur, mais de **réinstaller la Présence divine (ḥuḍūr Allāh)** dans le cœur blessé. Allah dit :

« Allah est le Protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » (Coran 2, 257)

Cette sortie des ténèbres n'est pas instantanée. Elle est un **chemin**. Dans les cultures africaines, ce passage est souvent comparé à une **initiation** : l'homme quitte un état ancien pour apprendre à vivre autrement, avec de nouveaux repères spirituels.

II. ANTHROPOLOGIE SPIRITUELLE ISLAMO-AFRICAINE DE LA GUERISON

1. Le handicap spirituel comme amnésie du cœur

Dans la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, le handicap spirituel n'est pas assimilé à une malédiction définitive. Il est compris comme une **amnésie profonde** : l'homme a oublié qui il est, d'où il vient et vers qui il marche. Le Coran décrit cet état :

« Ils ont oublié Allah, et Il leur a fait oublier leurs propres âmes. » (Coran 59, 19)

Cette amnésie se manifeste par :

- la peur constante,
- la suspicion généralisée,
- la dépendance aux protections magiques,
- la fragmentation de la foi.

En Afrique noire, où l'identité est relationnelle et communautaire, cette perte de repères spirituels provoque une **désagrégation de la personne**.

2. Corps, âme et esprit : une unité thérapeutique

L'anthropologie médicale africaine, en dialogue avec l'Islam, refuse la séparation radicale entre corps et esprit. Le Coran parle du **qalb**, non comme un organe biologique, mais comme le **centre de perception spirituelle**.

Lorsque le qalb est malade, le corps peut souffrir ; lorsque le corps est affaibli, l'âme devient vulnérable. La thérapie spirituelle islamique encadrée prend donc en compte :

- la parole,
- le souffle,
- la posture corporelle,
- le rythme de vie.

Cette approche holistique rejoint profondément les traditions africaines de guérison intégrale.

III. Le Coran comme matrice thérapeutique vivante

1. Le Coran, Shifā' des poitrines

Le Coran se présente explicitement comme **guérison** :

« Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » (Coran 17, 82)

Dans la phase 2 de la MTHS, le Coran n'est pas utilisé comme un talisman, mais comme une **présence structurante**. Il rééduque le regard du malade, réforme sa compréhension du monde invisible et réoriente sa relation à Dieu.

Chaque verset agit comme une **reprogrammation douce** de l'imaginaire spirituel.

2. Récitation et vibration : une thérapeutique de l'oralité

L'Islam africain a toujours accordé une place centrale à l'oralité. La récitation coranique, lorsqu'elle est lente, articulée et respectueuse des règles du tajwīd, agit comme une **vibration ordonnatrice**.

Le malade n'est pas toujours invité à comprendre immédiatement le sens intellectuel. Il est d'abord invité à **recevoir**. Dans de nombreuses communautés africaines, on dit que « la Parole soigne avant d'expliquer ».

La récitation agit alors :

- sur les peurs enfouies,
- sur les tensions du corps,
- sur les résistances invisibles.

3. Tadabbur : intérioriser la Parole

Le tadabbur – méditation intérieure du Coran – marque une étape décisive. Le malade apprend progressivement à **écouter la Parole en lui-même**. Cette intériorisation transforme le Coran en **compagnon thérapeutique**, et non en simple texte récité par un tiers. Ainsi commence la **reconstruction autonome de la vie spirituelle**.

Lorsque la Parole divine commence à réhabiter le cœur, lorsque la peur cède la place à une première forme de confiance, le malade entre dans une nouvelle étape. Il ne s'agit plus seulement d'écouter, mais de **participer activement à sa propre guérison**.

C'est à ce moment précis que le **dhikr** et la **du'ā** prennent toute leur profondeur thérapeutique. Ils ne sont plus des formules récitées par crainte, mais des **gestes conscients de réappropriation spirituelle**.

Section-2: PRATIQUES ACTIVES DE RÉÉDUCATION SPIRITUELLE

INTRODUCTION

De la réception à l'action consciente

Après avoir accueilli la Parole comme matrice de reconstruction intérieure, le malade n'est plus un simple réceptacle passif. La thérapie spirituelle islamique encadrée l'invite désormais à **entrer activement dans le processus de guérison**. Cette transition

marque un tournant décisif : l'homme blessé commence à redevenir **acteur de sa propre restauration**.

Dans la sagesse africaine, on dit que « la main qui reçoit doit apprendre à donner ». Dans la MTHS, cela signifie que le cœur, une fois apaisé par le Coran, doit apprendre à **se mouvoir spirituellement**, à respirer à nouveau dans le souvenir de Dieu et à parler sans peur devant Lui.

C'est dans cette dynamique que s'inscrivent le **dhikr** et la **du'ā** : non comme des rituels mécaniques, mais comme des **exercices thérapeutiques structurants**, capables de rééduquer l'âme blessée et de lui rendre sa verticalité.

IV. LE DHIKR : REEDUCATION VIBRATOIRE DE L'AME BLESSEE

1. Le dhikr comme restauration de la mémoire spirituelle

Le terme *dhikr* signifie littéralement « rappel ». Or, dans la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, la plupart des troubles spirituels profonds sont interprétés comme une **perte de mémoire intérieure**. L'homme ne se souvient plus de Dieu comme source de protection ; il se souvient surtout de ses peurs, de ses ennemis supposés et de ses blessures héritées. Allah dit :

« Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah ; Il leur a fait oublier leurs propres âmes. » (Coran 59, 19).

Le dhikr agit comme une **thérapie du souvenir**. À force de répéter le Nom divin, l'âme retrouve peu à peu son axe. Ce n'est pas la quantité qui soigne, mais la **régularité accompagnée de présence**.

2. Le Nom divin comme vibration réparatrice

Dans la tradition soufie africaine, le Nom de Dieu n'est jamais une simple syllabe. Il est une **présence vibrante**. Répéter *Allāh, Raḥmān, Raḥīm*, c'est exposer l'âme blessée à une onde de miséricorde qui dissout lentement les nœuds intérieurs.

Dans de nombreuses confréries africaines, le dhikr est comparé à :

- une eau qui lave,
- un feu qui purifie,
- un souffle qui réanime.

Cette symbolique rejoint l'anthropologie africaine du **souffle vital**, où la parole sacrée rétablit la circulation de la vie là où elle était bloquée.

3. Dhikr et pédagogie du rythme

La MTHS insiste sur un principe fondamental : **le dhikr doit être dosé**. Un handicapé spirituel n'est pas un ascète confirmé. Trop de dhikr, imposé brutalement, peut provoquer :

- agitation,
- confusion mentale,
- exacerbation des peurs.

C'est pourquoi le thérapeute spirituel encadré :

- commence par de courtes séances,
- privilégie la lenteur,
- observe les réactions corporelles et émotionnelles.

Le rythme devient ici un **outil clinique**. Il permet à l'âme de s'habituer progressivement à la Présence divine sans être submergée.

4. Dhikr corporel et traditions africaines

Dans l'Islam africain incarné, le corps n'est pas exclu du dhikr. Le balancement léger, la respiration synchronisée, la posture assise ou debout font partie intégrante de la thérapie.

Ces gestes rejoignent les traditions africaines où la guérison passe par :

- le mouvement mesuré,
- la respiration consciente,
- l'harmonisation du corps et de l'esprit.

Le dhikr devient alors une **rééducation globale**, qui réinscrit la foi dans le corps lui-même.

V. La du'ā : parole réparatrice et re-humanisation du malade

1. Du'ā : parler à Dieu sans intermédiaire oppressant

Dans de nombreux contextes africains marqués par la peur de la sorcellerie, la relation au sacré est souvent médiatisée par des

figures perçues comme puissantes mais intimidantes. La du'ā, telle qu'enseignée par l'Islam, brise cette logique.

Le Prophète ﷺ a dit :

« Lorsque l'un de vous invoque, qu'il invoque avec certitude, car Allah ne contraint personne. »

La du'ā réhumanise le malade en lui rappelant qu'il peut **parler directement à Dieu**, sans masque, sans formule magique, sans marchandage.

2. La du'ā comme acte de subjectivation

Dans la MTHS, la du'ā est comprise comme un acte de **subjectivation thérapeutique**. Le malade cesse d'être un objet de soins pour devenir un **sujet parlant**. Il nomme :

- ses peurs,
- ses blessures,
- ses colères,
- ses espérances.

Cette parole libère l'âme du silence destructeur. Dans les cultures africaines, on dit que « la parole retenue rend malade ». La du'ā devient alors une **parole qui soigne**.

3. Pédagogie de la confiance et sortie de la peur

La thérapie islamique encadrée enseigne progressivement au malade :

- à demander sans exiger,
- à espérer sans désespérer,
- à accepter sans se résigner.

Allah dit :

« Invoquez-Moi, Je vous répondrai. » (Coran 40, 60)

Cette promesse divine est un pilier de la rééducation spirituelle. Elle aide le patient à quitter une religion de la peur pour entrer dans une **spiritualité de confiance**.

4. Du'ā communautaire et reconstruction du lien social

En Afrique noire, la guérison ne concerne jamais uniquement l'individu. La du'ā peut être :

- personnelle,
- familiale,
- communautaire.

Lorsqu'elle est encadrée, elle permet au malade de **réintégrer la communauté croyante**, non comme un danger spirituel, mais comme un espace de soutien et de prière partagée.

À ce stade du parcours, le malade a appris à :

- écouter la Parole,
- se souvenir de Dieu,
- parler sans peur devant Lui.

Cependant, une question demeure : **que faire des influences persistantes**, des troubles récurrents, des peurs qui résistent malgré la rééducation spirituelle ? C'est ici qu'intervient la question délicate de la **ruqyah**, de ses limites, de ses dérives et de son juste usage.

Section-3: DISCERNEMENT, LIMITES ET MATURATION SPIRITUELLE

INTRODUCTION

Quand la guérison exige le discernement

Dans le parcours thérapeutique, il arrive un moment où la progression spirituelle appelle non plus l'intensification des pratiques, mais leur **mise en ordre**. Après la réception du Coran, la rééducation par le dhikr et la restauration de la parole par la du'ā, l'âme blessée retrouve un certain équilibre. Pourtant, des résistances subsistent parfois : troubles persistants, peurs récurrentes, manifestations invisibles que le malade interprète comme des attaques renouvelées.

C'est à ce carrefour que se pose la question de la **ruqyah**. Mal comprise, mal encadrée ou absolutisée, elle peut devenir un facteur de dépendance et de confusion. Intégrée avec discernement, elle reste un **outil ponctuel de stabilisation**, au service d'une guérison plus profonde.

La sagesse islamique africaine enseigne que **tout ce qui libère sans éduquer asservit autrement**. La ruqyah n'échappe pas à cette règle.

VI. LA RUQYAH : SENS, LEGITIMITE ET FONDEMENTS ISLAMIQUES

1. Définition authentique de la ruqyah

Dans la tradition islamique, la ruqyah désigne une **supplication thérapeutique** fondée sur :

- des versets du Coran,
- des invocations prophétiques,
- l'affirmation exclusive du tawḥīd.

Le Prophète ﷺ a autorisé la ruqyah en ces termes :

« Exposez-moi vos ruqyah. Il n'y a aucun mal à la ruqyah tant qu'elle ne contient pas de shirk. »

La ruqyah n'est donc ni magique ni autonome. Elle ne tire son efficacité que de la **Parole de Dieu** et de la **confiance en Lui**.

2. Ruqyah et fonction clinique dans la MTHS

Dans la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, la ruqyah est intégrée comme un **acte ponctuel**, jamais comme une thérapie permanente. Elle intervient :

- lorsque certaines manifestations persistent,
- lorsque le patient est suffisamment stabilisé,
- lorsque la pratique est encadrée par un thérapeute formé.

La ruqyah agit alors comme une **aide à la pacification**, et non comme une solution totale.

VII. LIMITES THERAPEUTIQUES ET DERIVES CONTEMPORAINES

1. La ruqyah transformée en spectacle

Dans plusieurs contextes africains, la ruqyah a été détournée :

- en démonstrations publiques,
- en pratiques violentes,
- en marchandisation de la peur.

Ces dérives produisent souvent :

- une fragilisation psychologique,
- une dépendance au thérapeute,
- une exacerbation des troubles.

La MTHS condamne fermement toute ruqyah qui :

- humilie le malade,
- provoque des cris, des violences ou des traumatismes,
- remplace la pédagogie par la contrainte.

2. Confusion entre ruqyah et pratiques magiques

L'une des grandes dérives observées est la **confusion entre ruqyah islamique et pratiques magiques syncrétiques**. Amulettes, formules opaques, gestes ésotériques ou promesses de protection absolue contredisent l'esprit du tawḥīd.

Dans l'Islam africain authentique, la guérison ne s'achète pas et ne se fétichise pas. Elle se **reçoit dans la patience et la foi**.

3. La ruqyah comme dernier recours, non comme système

La sagesse thérapeutique enseigne que **plus un outil est puissant, plus son usage doit être limité**. La ruqyah ne doit jamais devenir :

- une pratique quotidienne systématique,
- une solution à toute difficulté,
- un substitut à l'éducation spirituelle.

Lorsqu'elle est répétée sans discernement, elle entretient l'idée que le mal est omniprésent et invincible, ce qui contredit la pédagogie coranique de la confiance.

VIII. REEDUCATION SPIRITUELLE PROGRESSIVE : CŒUR DE LA PHASE 2 MTHS

1. De la délivrance à la stabilisation intérieure

La finalité de la thérapie spirituelle islamique n'est pas la disparition totale de toute épreuve, mais la **capacité du patient à vivre avec foi, discernement et paix**.

La rééducation spirituelle progressive vise :

- la régularité dans la prière,
- la structuration du temps spirituel,
- la stabilité émotionnelle,
- l'autonomie face aux peurs invisibles.

Le malade apprend à distinguer :

- l'épreuve normale de la vie,
- de l'obsession spirituelle.

2. Autonomie spirituelle et responsabilité

La MTHS insiste sur un principe fondamental : **le thérapeute doit progressivement s'effacer**. Un patient guéri est un patient qui n'a plus besoin d'un thérapeute permanent.

Cette autonomie se manifeste par :

- une pratique religieuse simple et régulière,

- une confiance apaisée en Dieu,
- une capacité à affronter les difficultés sans panique.

3. Réintégration sociale et communautaire

En Afrique noire, la guérison spirituelle est incomplète si elle ne se traduit pas par une **réintégration harmonieuse dans la communauté**. Le patient retrouve sa place :

- dans la famille,
- dans la mosquée,
- dans les cercles sociaux.

La thérapie devient alors **réparation du lien social**, non enfermement spirituel.

CONCLUSION

Vers un Islam africain thérapeutique et incarné

La thérapie spirituelle islamique encadrée, telle que développée dans la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, propose une voie équilibrée entre foi et discernement, entre héritage africain et rigueur islamique, entre délivrance et maturation.

Elle refuse la peur comme moteur religieux. Elle refuse la violence comme méthode thérapeutique. Elle choisit la **miséricorde, la pédagogie et la lenteur**, à l'image du Dieu qui guérit les cœurs avant de juger les actes.

Dans un continent marqué par les blessures invisibles de l'histoire, l'Islam africain est appelé à redevenir ce qu'il a toujours été dans sa profondeur : **une voie de guérison, de dignité et de réconciliation intérieure.**

CHAPITRE-12 :
**APPROCHE SYMBOLIQUE ET
RESTAURATION INTÉRIEURE**
(La phase 3 de la MTHS)

Section-1 : LA PEUR SYMBOLIQUE ET SES RACINES
ANTHROPO-SPIRITUELLES**

INTRODUCTION

Quand le mal n'habite plus les faits, mais les symboles

À ce stade du parcours thérapeutique, le mal n'est plus frontal. Il ne se manifeste plus nécessairement par des crises, des troubles aigus ou des attaques visibles. Il s'est déplacé. Il s'est **replié dans les profondeurs de l'imaginaire**, dans les symboles intériorisés, dans les images mentales héritées, transmises, parfois jamais questionnées.

La phase 3 de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels commence précisément là où beaucoup de thérapies s'arrêtent trop tôt :

- ☞ **au niveau du sens,**
- ☞ **au niveau de la représentation,**
- ☞ **au niveau de la peur symbolique.**

Dans les sociétés d'Afrique noire, la peur n'est pas seulement une émotion : elle est une **structure de pensée**, un langage, parfois même une vision du monde. Lorsqu'elle n'est pas travaillée, elle continue d'agir même après la délivrance, sabotant la guérison intérieure et maintenant le sujet dans une vigilance malade.

I. COMPRENDRE LA PEUR SYMBOLIQUE DANS L'ANTHROPOLOGIE AFRICAINE

1. La peur comme héritage collectif

Dans l'anthropologie médicale africaine, la peur ne naît jamais ex nihilo. Elle est souvent **héritée**, transmise par :

- les récits familiaux,
- les mythes communautaires,
- les traumatismes historiques (esclavage, colonisation, guerres),
- les discours religieux mal intégrés.

Ainsi, un individu peut être spirituellement stabilisé, pratiquer correctement sa foi, tout en restant **habité par des images de menace** : sorcier nocturne, esprit ancestral vengeur, jalousie invisible, parole maléfique. Ces images fonctionnent comme des **symboles toxiques**.

2. La peur symbolique comme maladie du sens

La MTHS considère que la peur symbolique est une **pathologie du sens**. Ce n'est plus le mal qui agit directement, mais **l'interprétation du monde** qui devient malade. Le Coran éclaire cette réalité lorsqu'il dit : « **C'est dans les cœurs que sont les maladies.** » (Coran 2, 10)

Dans cette perspective, le cœur n'est pas seulement affectif ; il est **le siège du regard intérieur**. Lorsque ce regard est déformé, l'homme vit dans un monde perçu comme hostile, même lorsque Dieu l'a déjà libéré.

II. THEOLOGIE FONDAMENTALE DE LA PEUR ET DE LA SECURITE INTERIEURE

1. La peur : entre épreuve et illusion

L'Islam ne nie pas la peur. Il la reconnaît comme une **épreuve existentielle**. Mais il distingue clairement :

- la peur éducative (khawf), qui oriente vers Dieu,
- de la peur pathologique, qui enferme et paralyse.

Allah dit : « ***N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants.*** » (Coran 3, 175)

La thérapie spirituelle islamique encadrée vise précisément à **déplacer l'objet de la peur** : des forces invisibles imaginées vers **la conscience responsable devant Dieu**.

2. Quand la peur devient idolâtrie symbolique

Dans la MTHS, une affirmation forte est posée, avec prudence mais clarté :

☞ **toute peur qui gouverne la vie intérieure devient une forme subtile d'idolâtrie.**

Craindre excessivement la sorcellerie, les esprits, les hommes, les paroles, c'est parfois leur attribuer un pouvoir qu'ils n'ont pas. Le Coran rappelle :

« Allah est plus digne d'être craint, si vous êtes croyants. » (Coran 9, 13)

La phase 3 consiste donc à **désacraliser les symboles de peur**, sans nier l'existence du monde invisible, mais en le replaçant sous l'autorité absolue de Dieu.

III. FONCTION THERAPEUTIQUE DU SYMBOLE DANS LA MTHS

1. Le symbole : lieu de blessure et lieu de guérison

En Afrique noire, le symbole n'est jamais neutre. Il structure la mémoire, le rapport au corps, à la nuit, à la parole, à la mort. Lorsqu'il est toxique, il enferme. Lorsqu'il est purifié, il libère.

La MTHS ne détruit pas les symboles culturels. Elle les **retravaille**, les **désactive**, les **réoriente**.

Exemple :
la nuit, souvent associée au mal, peut redevenir :

- un temps de repos,
- un espace de prière,
- un lieu de protection divine.

2. L'Islam africain comme relecture symbolique

L'inculturation de l'Islam en Afrique noire n'a jamais consisté à nier les symboles africains, mais à leur offrir **un nouveau centre de gravité**.

La Kaaba elle-même est un symbole. Le jeûne est un symbole. La prière est un symbole corporel. L'Islam ne combat pas le symbolique ; il le **convertit**.

Ainsi, la phase 3 MTHS travaille à :

- purifier l'imaginaire,
- réorienter les images mentales,
- restaurer un langage intérieur pacifié.

Lorsque la peur n'est plus identifiée comme une fatalité, mais comme une **construction symbolique**, le malade devient capable d'un pas décisif :

☞ **désactiver les représentations toxiques qui gouvernaient son monde intérieur.**

Section-2: DÉSACTIVATION DES REPRÉSENTATIONS **TOXIQUES ET GUÉRISON DE L'IMAGINAIRE**

INTRODUCTION

Quand le mal survit dans l'imaginaire

Après la délivrance, après la stabilisation spirituelle, beaucoup de souffrants continuent à vivre comme si le danger était toujours imminent. Le corps est apaisé, la prière rétablie, la foi confessée... mais l'esprit demeure captif d'images anciennes. La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels nomme cet état : **la survie symbolique du mal**.

Ce n'est plus la sorcellerie réelle qui agit, mais sa **représentation intérieure**. Ce n'est plus l'attaque, mais l'attente de l'attaque. Ce n'est plus l'ennemi invisible, mais son **image logée dans la conscience**.

La phase 3 MTHS reconnaît ici une vérité fondamentale :
☞ **on peut être délivré sans être guéri intérieurement,**
☞ **on peut croire en Dieu tout en continuant à voir le monde à travers la peur.**

C'est pourquoi la guérison de l'imaginaire devient une étape incontournable.

IV. COMPRENDRE LES REPRESENTATIONS TOXIQUES

1. Définition des représentations toxiques

Les représentations toxiques sont des **images mentales chargées d'affect négatif**, construites par :

- l'éducation implicite,
- les récits culturels,
- les traumatismes familiaux,
- les discours religieux non intégrés.

Elles fonctionnent comme des **logiciels invisibles**, orientant les réactions, les interprétations et même les rêves.

Exemples fréquents en Afrique noire :

- la nuit comme espace exclusif du mal,
- la réussite comme provocation spirituelle,
- la maladie comme punition mystique,
- le regard d'autrui comme menace permanente.

2. Représentation et réalité : une confusion pathologique

Dans la MTHS, la pathologie ne réside pas dans l'existence de ces symboles, mais dans leur **absolutisation**. Le symbole n'est plus un langage, il devient une prison.

Le Coran attire l'attention sur cette confusion :

« La plupart d'entre eux ne suivent que conjecture et imagination. » (Coran 10, 36)

Lorsque l'imaginaire gouverne la foi, la foi devient fragile. La thérapie spirituelle vise alors une **rééducation du regard intérieur**.

V. DESACTIVATION THERAPEUTIQUE DES REPRESENTATIONS TOXIQUES

1. Nommer pour désactiver

Le premier acte thérapeutique consiste à **nommer la représentation toxique**. Ce qui est nommé cesse d'être omnipotent. Dans les traditions africaines, nommer un esprit ou une peur, c'est déjà **reprendre du pouvoir sur elle**. La MTHS intègre cette sagesse, en l'orientant vers la vérité théologique.

Le thérapeute accompagne le patient à identifier :

- ce qu'il imagine,
- ce qu'il craint,
- ce qu'il projette.

Sans jugement. Sans moquerie. Avec respect.

2. Distinguer le possible du probable

Une étape essentielle de la désactivation consiste à réintroduire la **hiérarchie du réel**. Tout ce qui est possible n'est pas probable ; tout ce qui est imaginable n'est pas réel.

Le Coran enseigne cette sobriété du regard :

« Allah ne veut pour vous ni la gêne ni la difficulté. »
(Coran 5, 6)

La thérapie apprend au patient à quitter une lecture catastrophiste du monde pour entrer dans une **lecture confiante mais lucide**.

3. Démythifier sans humilier

La MTHS insiste sur une règle éthique :
 **on ne guérit pas un imaginaire blessé par la violence intellectuelle.** Détruire brutalement les croyances d'un patient produit une fracture identitaire. Il faut au contraire **désamorcer progressivement**, en respectant le chemin intérieur.

L'Islam africain a toujours privilégié cette pédagogie douce, héritée des maîtres soufis : on ne brise pas l'image, on la **transfigure**.

VI. GUERISON DE L'IMAGINAIRE PAR LE CORAN ET LA SYMBOLIQUE ISLAMIQUE

1. Le Coran comme correcteur d'imaginaire

Le Coran ne se contente pas d'ordonner. Il **reconfigure l'imaginaire**. Il propose de nouvelles images :

- Dieu comme Protecteur,
- la nuit comme signe,
- l'épreuve comme purification,
- la patience comme victoire.

Allah dit :

« Il a fait de la nuit et du jour deux signes. »

(Coran 17, 12)

La nuit n'est donc plus l'espace du mal, mais un **signe divin**.

2. Rituels symboliques et réappropriation du corps

La prière, le jeûne, l'ablution, la prosternation sont autant de **gestes symboliques thérapeutiques**. Ils rééduquent le corps à ne plus associer certains espaces ou moments à la peur.

Se prosterner la nuit devient alors un acte de **désactivation symbolique** : ce qui était redouté devient sanctifié.

3. Réécriture intérieure des récits

Dans la phase 3 MTHS, le patient est invité à **réécrire son récit intérieur** :

- non plus comme victime permanente,
- mais comme croyant accompagné.

Cette réécriture est une guérison narrative. Elle libère l'âme de la fatalité.

VII. ANTHROPOLOGIE AFRICAINE ET RECONSTRUCTION DE L'IMAGINAIRE COLLECTIF

1. L'imaginaire n'est jamais individuel

En Afrique noire, l'imaginaire est collectif. Guérir un individu sans toucher son environnement symbolique revient à l'exposer à une rechute.

La MTHS encourage donc :

- le dialogue familial,
- la clarification communautaire,
- la transmission d'un discours apaisé.

2. Islam africain et responsabilité éducative

Les leaders religieux, les thérapeutes spirituels, les anciens ont une responsabilité immense :

☞ **ne pas entretenir un imaginaire de peur.**

L'Islam africain authentique est appelé à devenir un **espace de guérison symbolique collective.**

Lorsque les représentations toxiques sont identifiées, nommées et désactivées, un espace nouveau s'ouvre dans l'âme : **l'espace de la réconciliation.**

Réconciliation avec soi-même, longtemps perçu comme fragile ou menacé.

Réconciliation avec Dieu, parfois vécu comme juge lointain plutôt que comme Miséricorde.

Section-3 : RÉCONCILIATION AVEC SOI, AVEC DIEU ET AVEC LE MONDE

(Achèvement de la phase 3 de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels)

INTRODUCTION

Lorsque l'âme cesse de se méfier de la vie

La restauration intérieure commence véritablement lorsque l'âme n'est plus en état de défense permanente. Tant que le sujet se protège contre des dangers imaginés, tant qu'il se soupçonne lui-même d'être vulnérable ou maudit, la guérison reste incomplète.

La phase 3 de la MTHS atteint son sommet lorsque le patient **cesse de se vivre comme un survivant spirituel** pour se reconnaître comme un **être réconcilié**.

La réconciliation n'est pas l'oubli du passé, ni la négation des blessures. Elle est une **réintégration pacifiée** de l'histoire personnelle, familiale et spirituelle. Elle marque le passage d'une spiritualité de la survie à une spiritualité de la confiance.

Dans la sagesse africaine, on dit que « l'homme guéri est celui qui peut dormir sans guetter la nuit ». Cette image résume profondément l'objectif de la restauration intérieure.

VIII. RECONCILIATION AVEC SOI : RESTAURER L'IMAGE INTERIEURE

1. De l'auto-suspicion à l'estime spirituelle

Le handicap spirituel laisse souvent des traces durables dans la perception de soi. Même après la délivrance, le sujet peut continuer à se percevoir comme :

- fragile,
- spirituellement exposé,
- porteur d'une faille invisible.

La MTHS identifie ici une **blessure de l'image intérieure**. L'individu doute de sa capacité à être stable, à être protégé, à être digne de la proximité divine.

Or, le Coran affirme avec force :

« *Nous avons certes honoré les fils d'Adam.* »
(Coran 17, 70)

La réconciliation avec soi consiste à **réintégrer cette dignité** comme donnée fondamentale, non comme récompense conditionnelle.

2. Le cœur (qalb) comme lieu de restauration

Dans la théologie islamique, le qalb est un lieu mobile, capable de se retourner, de guérir, de se purifier. La restauration intérieure n'exige pas un cœur parfait, mais un cœur **vivant, conscient et confiant**.

La MTHS enseigne que le cœur guéri :

- n'est pas exempt d'émotions,
- mais il n'est plus dominé par elles,
- il reconnaît ses limites sans s'y enfermer.

Cette pacification intérieure est un signe de maturité spirituelle.

3. Réintégrer son histoire sans culpabilité

La réconciliation avec soi implique aussi une **rélecture pacifiée du passé**. Le sujet apprend à ne plus interpréter chaque épreuve comme une preuve de malédiction ou d'échec spirituel. Le Coran rappelle :

« Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » (Coran 2, 286)

Cette parole devient un socle thérapeutique : ce qui a été vécu n'était pas une condamnation, mais une étape possible dans un chemin plus vaste.

IX. RECONCILIATION AVEC DIEU : DE LA PEUR RELIGIEUSE A LA CONFIANCE FILIALE

1. Guérir l'image de Dieu

Dans de nombreux contextes africains marqués par la peur spirituelle, Dieu peut être inconsciemment perçu comme :

- distant,
- constamment juge,
- prompt à punir.

La phase 3 de la MTHS identifie ici une **pathologie théologique intérieure** : le Dieu de la peur remplace le Dieu de la miséricorde.

Or, le Coran affirme :

« Ma miséricorde embrasse toute chose. »

(Coran 7, 156)

La restauration intérieure passe par une **réconciliation avec le visage miséricordieux de Dieu**.

2. Tawhīd vécu et sécurité intérieure

Le tawhīd, compris non seulement comme doctrine mais comme **expérience intérieure**, devient un puissant facteur de guérison. Lorsque Dieu est reconnu comme l'unique source de protection, les autres peurs perdent leur pouvoir symbolique.

Allah dit :

« Celui qui place sa confiance en Allah, Il lui suffit. »

(Coran 65, 3)

Cette suffisance divine ne supprime pas les difficultés, mais elle **désactive l'angoisse existentielle**.

3. La foi comme relation apaisée

La MTHS enseigne que la foi mature n'est ni naïve ni anxieuse. Elle est **relationnelle**. Elle accepte l'incertitude sans sombrer dans la peur. Elle transforme la prière en espace de repos, non de tension.

La réconciliation avec Dieu se manifeste lorsque :

- la prière devient refuge,
- le Coran devient compagnon,
- et non arme contre des menaces imaginées.

X. RECONCILIATION AVEC LE MONDE : SORTIR DE LA VIGILANCE PERMANENTE

1. Quitter la lecture hostile de la réalité

Un imaginaire blessé lit le monde comme un champ de menaces. La restauration intérieure permet au sujet de retrouver une **lecture nuancée et confiante** de la réalité.

Le Coran invite à cette posture :

« C'est Lui qui a soumis pour vous tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. » (Coran 45, 13)

Le monde redevient un espace habitable, non un piège spirituel.

2. Restaurer le lien social et communautaire

La peur symbolique isole. La guérison réconcilie. En Afrique noire, la restauration intérieure se vérifie dans la **qualité des relations** :

- capacité à faire confiance,
- diminution de la suspicion,
- retour à la participation communautaire.

La MTHS considère la réintégration sociale comme un **indicateur clinique de guérison profonde**.

3. Spiritualité incarnée et responsabilité

La phase 3 ne conduit pas à une fuite du monde, mais à une **spiritualité incarnée**, responsable, lucide. Le sujet guéri devient capable de discernement sans paranoïa, de prudence sans obsession.

CONCLUSION

La paix comme signe de guérison

La phase 3 de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels marque l'aboutissement du processus thérapeutique : **la restauration intérieure par la guérison du sens, du symbole et de la relation.**

L'approche symbolique ne nie ni le monde invisible, ni les réalités culturelles africaines. Elle les **réoriente** vers un centre stable : Dieu, source de paix et de dignité.

Dans l'Islam africain incarné, la guérison ultime n'est pas l'absence totale d'épreuves, mais la capacité de **vivre sans peur dominatrice**, en confiance devant Dieu et devant la vie.

Ainsi se referme le cycle initiatique de la MTHS :

- ☞ de la reconnaissance du mal,
- ☞ à la délivrance,
- ☞ à la reconstruction,
- ☞ jusqu'à la **réconciliation intérieure.**

PARTIE-V :
GUÉRIR, RÉINTÉGRER, PRÉVENIR
(Phase de consolidation et de prévention)

CHAPITRE-13 :

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION

De la guérison individuelle à la restauration communautaire

Dans les sociétés africaines traditionnelles, la maladie – qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle – n'est jamais strictement individuelle. Elle est toujours relationnelle, communautaire et symbolique. Lorsqu'un être souffre, c'est un tissu complexe de liens visibles et invisibles qui se trouve fragilisé : la famille nucléaire et élargie, le clan, la communauté villageoise, les ancêtres, les forces spirituelles, mais aussi le rapport intime à Dieu, à soi-même et au sens de l'existence.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS), telle que conceptualisée et pratiquée par l'Association Mariale d'Abili (ASMAB), s'inscrit pleinement dans cette vision holistique. Elle refuse toute réduction de la souffrance spirituelle à un simple dysfonctionnement intérieur ou à une causalité unique. Elle reconnaît au contraire la pluralité des causes, des manifestations et des conséquences du handicap spirituel.

Dans ce cadre, la cure de désenvoûtement et la délivrance spirituelle ne constituent jamais une fin en soi. Elles ouvrent un processus plus long, plus délicat et souvent plus déterminant :

l'accompagnement psychosocial et communautaire. Cette étape correspond à ce que l'on pourrait appeler le temps de la consolidation, de la protection et de la réintégration. Elle vise à empêcher les rechutes, à désamorcer les violences sociales liées aux accusations et à restaurer la dignité du patient au sein de son milieu de vie.

Ce chapitre se présente ainsi comme une immersion progressive, presque initiatique, dans cette phase décisive du suivi MTHS. Il adopte une écriture volontairement incarnée, narrative et réflexive, afin que le lecteur ne soit pas seulement informé, mais intérieurement conduit à comprendre que la guérison spirituelle véritable ne s'achève que lorsque la personne retrouve sa place parmi les vivants, dans la paix et la reconnaissance.

I. FONDEMENTS THEOLOGIQUES, SPIRITUELS ET ANTHROPOLOGIQUES DE L'ACCOMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE

1. La personne humaine comme carrefour de relations visibles et invisibles dans le Coran et la sagesse africaine

Dans l'anthropologie africaine traditionnelle, l'être humain n'est jamais conçu comme un individu isolé. Il est un nœud de relations, un point d'intersection entre plusieurs mondes : le monde des vivants, celui des ancêtres, le monde naturel, le monde spirituel et le monde divin. Cette vision rejoint profondément la conception islamique de l'être humain comme *khalîfa*, dépositaire d'une responsabilité cosmique et relationnelle confiée par Dieu.

Le Coran rappelle que Dieu a créé l'être humain « dans la plus belle des formes » (Coran 95:4) et qu'Il a insufflé en lui de Son Esprit (Coran 15:29). Cette insufflation divine fonde la dignité de la personne, mais aussi sa vulnérabilité : lorsque les équilibres relationnels sont rompus, c'est l'ensemble de l'être qui vacille.

Le Coran souligne également que l'humanité a été voulue plurielle : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez les uns les autres » (Coran 49:13). Cette connaissance mutuelle implique protection, solidarité et responsabilité communautaire face à la souffrance spirituelle de l'un des membres.

Dans ce contexte, le handicap spirituel apparaît rarement comme un phénomène strictement personnel. Il est souvent l'expression visible d'un déséquilibre relationnel profond : conflits familiaux anciens, jalousies accumulées, ruptures de filiation symbolique, paroles de malédiction, héritages spirituels mal assumés ou mauvaise médiation avec l'invisible.

2. La guérison comme restauration de l'*amânah* et de l'harmonie globale

Guérir, dans la perspective de la MTHS, ne signifie pas seulement neutraliser une attaque spirituelle ou lever un envoûtement. Guérir signifie restaurer l'*amânah* – le dépôt sacré confié par Dieu à l'être humain (Coran 33:72) – et rétablir l'harmonie

globale : harmonie intérieure (*nafs* apaisée), harmonie relationnelle, harmonie communautaire et harmonie spirituelle.

Cette compréhension rejoint la sagesse prophétique selon laquelle « ***les croyants, dans leur affection et leur miséricorde réciproques, sont semblables à un seul corps : lorsqu'un membre souffre, tout le corps veille et souffre avec lui*** ». Elle rejoint également la sagesse africaine affirmant qu'« un seul bras ne peut enlacer l'arbre ».

Dans la tradition soufie, la guérison est comprise comme un retour progressif à l'équilibre intérieur (*sukûn*), fruit de la proximité avec Dieu (*qurb*). L'accompagnement psychosocial devient alors un chemin de stabilisation du cœur (*qalb*) après la tempête spirituelle.

II. LA PROTECTION DU PATIENT : PREMIERE EXIGENCE ETHIQUE, SPIRITUELLE ET THERAPEUTIQUE

1. La vulnérabilité post-délivrance à la lumière du Coran

Après une cure de désenvoûtement ou une séance de délivrance spirituelle, le patient entre dans une phase de grande vulnérabilité. Les influences oppressives ont été neutralisées, mais les défenses intérieures et sociales ne sont pas encore consolidées.

Le Coran reconnaît explicitement cette fragilité constitutive de l'être humain : « Dieu veut vous alléger, car l'homme a été créé faible » (Coran 4:28). Cette faiblesse n'est pas une honte, mais un appel à la protection, à la douceur et à l'accompagnement.

Dans la MTHS, cette phase est assimilée à une période de *hifz* (préservation). Le patient doit être entouré, surveillé avec bienveillance et guidé avec sagesse, à l'image du nouveau croyant dont la foi naissante doit être protégée.

2. Éthique islamique de la discrétion et du secret thérapeutique

La protection du patient passe avant tout par la maîtrise de la parole. Dans les sociétés africaines, la parole est performative : elle crée ou détruit. L'Islam confirme cette puissance en rappelant que « l'homme ne prononce aucune parole sans qu'un observateur vigilant ne soit prêt à l'enregistrer » (Coran 50:18).

L'éthique thérapeutique islamique insiste sur la *saṭr* – le fait de couvrir les faiblesses d'autrui. Le Prophète (paix et salut sur lui) a enseigné que celui qui couvre la honte d'un croyant ici-bas, Dieu couvrira la sienne au Jour du Jugement.

Dans le suivi MTHS, cette éthique se traduit par :

- un secret absolu sur les causes spirituelles révélées ;
- une discipline de la parole familiale et communautaire ;
- une pédagogie du silence protecteur.

3. Protection spirituelle continue : *dhikr*, prières et médiations culturelles licites

La protection est également spirituelle. Elle inclut des pratiques régulières :

- récitations coraniques ciblées (Ayat al-Kursî, sourates protectrices) ;
- *dhikr* apaisant pour stabiliser le cœur ;
- prières d'invocation adaptées à la situation du patient ;
- objets symboliques culturellement reconnus, purifiés de toute forme d'associationnisme.

Cette démarche s'inscrit dans une inculturation responsable de l'Islam, où la culture devient support de la foi sans jamais se substituer à Dieu.

III. DESAMORÇAGE DES ACCUSATIONS : GUERIR LA PAROLE, PACIFIER LA MEMOIRE COLLECTIVE

1. Les accusations de sorcellerie à l'épreuve de l'éthique islamique

Dans de nombreux contextes africains, la souffrance spirituelle déclenche une quête de coupables. Cette logique accusatrice entre souvent en tension avec l'éthique islamique, qui condamne les soupçons excessifs : « Ô vous qui avez cru ! Évitez de trop conjecturer, car certaines conjectures sont des péchés » (Coran 49:12).

La MTHS considère la prolifération des accusations comme une pathologie communautaire qui nourrit la peur, la violence symbolique et parfois la destruction physique.

2. Médiation communautaire et principe d'*islah*

Désamorcer les accusations exige un travail patient de médiation fondé sur le principe coranique de l'*islah* (réconciliation). Dieu affirme que la réconciliation est préférable à toute autre forme de règlement des conflits.

Le thérapeute ou le guide spirituel agit alors comme médiateur :

- il déplace la question du « qui est coupable ? » vers « comment restaurer la paix ? » ;
- il invite à la retenue verbale ;
- il rappelle la responsabilité collective dans la protection des plus vulnérables.

3. Gestes symboliques de pacification et spiritualité du pardon

Lorsque les tensions sont fortes, des gestes symboliques peuvent être proposés : repas partagés, prières collectives, paroles publiques de pardon. Dans la tradition soufie, le pardon est une purification du cœur qui libère autant celui qui pardonne que celui qui est pardonné.

IV. REHABILITATION SOCIALE : REDONNER UNE PLACE, UN NOM ET UNE DIGNITE

1. Les effets sociaux du handicap spirituel

Le handicap spirituel entraîne souvent une marginalisation profonde : perte de confiance, exclusion implicite, retrait des responsabilités, soupçons persistants. Même après la guérison spirituelle, ces traces sociales peuvent subsister longtemps.

La MTHS affirme que la guérison n'est complète que lorsque le patient retrouve une place reconnue et valorisée au sein de la communauté.

2. Accompagnement psychosocial individualisé

Chaque patient porte une histoire singulière. L'accompagnement psychosocial vise donc à :

- reconstruire l'estime de soi ;
- aider à relire l'épreuve sans honte ;
- redéfinir un projet de vie réaliste et porteur de sens.

Cette démarche rejoint la notion islamique de *tazkiyat an-nafs*, la purification et l'élévation progressive de l'âme.

3. Réintégration économique et symbolique

La dignité passe aussi par l'activité, la responsabilité et la contribution sociale. Lorsque cela est possible, le patient est encouragé à reprendre ou initier une activité valorisante. La communauté devient alors témoin visible de sa restauration.

V. TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE ET PREVENTION DES RECHUTES

1. Le patient guéri comme porteur d'enseignement

Dans la sagesse africaine, celui qui a traversé l'épreuve devient porteur d'un enseignement pour les autres. Sans exposition excessive, le patient restauré peut contribuer à prévenir d'autres drames en partageant une parole apaisée et responsable.

2. Renforcement du tissu communautaire

L'accompagnement psychosocial vise aussi à renforcer la capacité de la communauté à gérer les crises spirituelles sans violence, sans accusations et sans exclusion.

VI. Récit initiatique : le retour parmi les siens

Dans les traditions orales africaines, on raconte qu'un homme frappé par l'ombre avait perdu sa voix. Après la guérison, ce ne fut pas sa force qui revint d'abord, mais sa capacité à s'asseoir parmi les siens sans peur. Ainsi en est-il du patient accompagné en MTHS : il revient à la communauté non comme un héros, mais comme un être pacifié.

Ce retour silencieux est souvent plus puissant que les cris de victoire. Il enseigne à la communauté que la guérison véritable est toujours collective.

CONCLUSION

L'accompagnement psychosocial et communautaire constitue l'achèvement éthique, spirituel et thérapeutique de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels. Protection du patient, désamorçage des accusations et réhabilitation sociale ne sont pas des étapes secondaires, mais les sceaux visibles d'une guérison authentique.

Dans une Afrique traversée par la peur de l'invisible, la violence des soupçons et la fragmentation des liens sociaux, cette approche inculturée de l'Islam, nourrie de sagesse africaine, ouvre un chemin de paix, de responsabilité et de miséricorde partagée.

Ce chapitre invite ainsi le lecteur – thérapeute, guide spirituel, leader communautaire ou simple membre de la société – à devenir artisan de guérison collective, gardien de la dignité humaine et témoin d'une foi qui soigne autant les âmes que les relations.

CHAPITRE-14 :

ÉTUDES DE CAS CLINIQUES EN MTHS

INTRODUCTION

Dans toute tradition thérapeutique authentique, la théorie ne trouve sa légitimité que lorsqu'elle se laisse éprouver par la vie réelle. Les études de cas constituent ainsi la mémoire incarnée d'une médecine, le lieu où les concepts rencontrent les visages, où les principes abstraits deviennent des histoires humaines de souffrance, de résistance et de relèvement. Dans la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS), cette exigence est encore plus cruciale, car elle touche à l'invisible, au sacré, au lien fragile entre l'individu, la communauté et Dieu.

Ce chapitre propose une série d'études de cas cliniques anonymisées, recueillies dans divers contextes africains, afin d'illustrer, de valider et de questionner les fondements théologiques, anthropologiques et thérapeutiques de la MTHS. Chaque cas est présenté comme un récit initiatique : une descente dans l'épreuve, un temps de discernement et de cure, puis un chemin de restauration personnelle et communautaire. L'approche se veut à la fois clinique, spirituelle et éthique, fidèle à l'inculturation de l'Islam dans les réalités culturelles de l'Afrique noire.

Dans le Coran, Dieu dit : ***« Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants »*** (Coran

2,155). Les cas qui suivent sont autant de manifestations concrètes de cette épreuve, mais aussi de la miséricorde divine qui accompagne ceux qui persévèrent dans la foi et la quête de guérison.

CAS CLINIQUE I – Le silence de l’homme aux rêves brûlés

1. Présentation générale et contexte anthropologique

Le patient, que nous nommerons A., est un homme d’une quarantaine d’années, cultivateur, marié et père de quatre enfants. Originaire d’un village forestier d’Afrique centrale, il est décrit par son entourage comme autrefois dynamique, sociable et profondément religieux. Depuis plusieurs années, A. souffre de troubles du sommeil marqués par des rêves récurrents de poursuite, de feu et de nudité publique. Ces manifestations s’accompagnent d’un retrait social progressif, d’une perte de parole dans les assemblées communautaires et d’un sentiment persistant de honte.

Dans l’anthropologie médicale africaine, le rêve n’est jamais un simple phénomène psychique. Il est un espace de circulation entre les mondes, un lieu où se révèlent les déséquilibres spirituels, les attaques occultes ou les appels non entendus. Le silence d’A. est interprété par la communauté comme le signe d’un envoûtement ancien, possiblement lié à un conflit foncier ou familial.

2. Analyse clinique MTHS

Sur le plan clinique, la MTHS identifie chez A. un handicap spirituel de type dissociatif : la parole est comme retenue, le souffle court, la présence corporelle diminuée. Le patient ne se plaint pas d'une douleur physique précise, mais d'un épuisement de l'âme, que le Coran désigne comme « **ال صدر ضيق** » (resserrement de la poitrine).

L'entretien thérapeutique révèle une rupture ancienne avec un oncle maternel, détenteur de savoirs traditionnels, qui aurait proféré des paroles de malédiction. Dans la logique de la MTHS, la parole malveillante agit comme une flèche invisible, susceptible de traverser les générations si elle n'est pas neutralisée.

3. Lecture théologique et islamique

Du point de vue islamique, la situation d'A. est interprétée à la lumière du concept de sihr (sorcellerie) et de waswâs (insinuations). Le Coran rappelle : « Et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite pas » (Coran 2,102). Cependant, la théologie de la délivrance islamique insiste sur le fait que nul mal ne peut atteindre l'homme sans la permission de Dieu.

La cure s'appuie sur la récitation des sourates protectrices (Al-Falaq, An-Nâs), sur le dhikr régulier et sur une réconciliation progressive avec l'histoire familiale, sans confrontation violente. L'inspiration soufie met l'accent sur la purification du cœur (tazkiyat an-nafs) comme chemin de guérison durable.

4. Processus thérapeutique et désenvoûtement

Le processus de désenvoûtement s'étend sur plusieurs semaines. Il comprend :

- des séances de parole rituelle sécurisée,
- des bains symboliques à base de plantes locales,
- des temps de prière communautaire encadrée.

La cure ne vise pas seulement la suppression des symptômes, mais la restauration du lien entre A., sa communauté et Dieu. Peu à peu, le patient retrouve le sommeil, puis la capacité de s'asseoir parmi **les anciens sans peur**.

5. Enseignements thérapeutiques

Ce premier cas montre que la guérison spirituelle est indissociable de la réhabilitation sociale. La parole retrouvée n'est pas un exploit individuel, mais un don partagé. Comme le disent les maîtres soufis : « ***Le cœur guéri devient un lieu de repos pour les autres*** ».

CAS CLINIQUE II

La femme aux douleurs errantes et au nom dispersé

1. Présentation générale et contexte anthropologique

La patiente B. est une femme d'environ trente-cinq ans, mère de trois enfants, commerçante sur un marché périurbain. Elle consulte pour des douleurs corporelles diffuses, changeantes, sans localisation stable, accompagnées de pertes de mémoire

ponctuelles, d'un sentiment de dédoublement et d'un profond épuisement moral. Dans le discours communautaire, son nom est souvent associé à des rumeurs : on dit qu'elle « porte quelque chose », qu'elle est devenue instable depuis son dernier accouchement.

Dans l'anthropologie médicale africaine, ces symptômes sont fréquemment interprétés comme une atteinte du principe d'unité de la personne. Le corps, l'âme et le nom – qui fonde l'inscription sociale – ne circulent plus ensemble. La femme devient alors un être vulnérable aux projections accusatoires.

2. Analyse clinique MTHS

La MTHS identifie ici un handicap spirituel de type fragmentaire. La patiente ne présente pas de délire structuré, mais une dispersion de l'énergie vitale et de la mémoire symbolique. Le récit biographique révèle une série de conflits conjugaux, des humiliations publiques et une parole de rejet prononcée lors d'un rite familial interrompu.

3. Lecture théologique et islamique

L'Islam enseigne que l'être humain a été créé « dans la plus parfaite harmonie » (Coran 95,4). La rupture de cette harmonie appelle non une condamnation, mais une restauration. La théologie islamique de la miséricorde (*rahma*) et la sagesse soufie rappellent que Dieu est Celui qui rassemble ce qui est dispersé (*Al-Jâmi'*).

La cure s'appuie sur la réhabilitation du nom de la patiente, la récitation de versets de consolation (Coran 94,1-6) et un travail symbolique de réintégration corporelle.

4. Processus thérapeutique

Le traitement combine :

- des entretiens de narration guidée,
- des bains de purification post-natale inspirés des savoirs traditionnels,
- un accompagnement spirituel basé sur le dhikr doux et la respiration consciente.

5. Enseignements thérapeutiques

Ce cas enseigne que la guérison féminine est inséparable de la protection sociale. Restaurer la personne, c'est aussi neutraliser les paroles qui l'assignent à la honte.

CAS CLINIQUE III – L'enfant pris entre deux songes

1. Présentation et contexte

L'enfant C., âgé de neuf ans, est amené par sa grand-mère pour des crises nocturnes, des terreurs soudaines et un refus scolaire. L'enfant dit être « appelé la nuit » par des figures indistinctes. Dans la culture locale, ces manifestations sont parfois interprétées

comme un appel initiatique précoce ou comme une capture spirituelle.

2. Analyse clinique MTHS

La MTHS distingue ici un handicap spirituel de vulnérabilité : l'enfant n'est pas porteur d'un mal propre, mais exposé à un environnement symboliquement instable. La séparation parentale récente a fragilisé ses repères.

3. Lecture théologique et islamique

Le Prophète (paix sur lui) a rappelé que chaque enfant naît dans la *fitra*, la disposition originelle à Dieu. La thérapie vise donc la protection, non l'extraction violente.

4. Processus thérapeutique

La cure privilégie :

- la sécurisation affective,
- des invocations courtes avant le sommeil,
- la restauration d'un cadre familial rassurant.

5. Enseignements

Ce cas montre que la MTHS refuse toute dramatisation abusive de l'enfance et s'inscrit dans une éthique de la douceur.

CAS CLINIQUE IV – Le notable déchu et la peur du regard

1. Présentation

D., ancien responsable communautaire, consulte après une chute sociale brutale. Accusé implicitement de pratiques occultes, il vit reclus, rongé par la honte.

2. Analyse clinique

La MTHS identifie un handicap spirituel lié à la perte de statut et à la destruction symbolique du nom public.

3. Lecture théologique

Le Coran rappelle que l'honneur véritable vient de Dieu seul (Coran 49,13). La thérapie vise la désidolâtrisation du statut et la reconstruction intérieure.

4. Processus thérapeutique

Accompagnement spirituel, réintégration progressive dans des cercles neutres, travail sur l'humilité.

5. Enseignements

La guérison passe par l'acceptation d'une nouvelle place, pacifiée.

CAS CLINIQUE V – Le village divisé : étude de cas communautaire

1. Présentation

Un conflit autour d'une mort inexplicquée a entraîné une spirale d'accusations de sorcellerie dans un village.

2. Analyse MTHS

La MTHS parle ici de handicap spirituel collectif.

3. Lecture islamique

L'Islam condamne la suspicion destructrice (*su' adh-dhann*). La délivrance devient communautaire.

4. Processus thérapeutique

Cercles de parole, rituels de réconciliation, prière collective.

5. Enseignements

La guérison collective restaure la paix sociale.

SYNTHÈSE TRANSVERSALE ET VALIDATION EMPIRIQUE

L'ensemble de ces cas confirme la validité empirique de la MTHS comme médecine intégrative. Les guérisons observées ne relèvent ni de la suggestion ni de la simple croyance, mais d'un travail rigoureux sur les dimensions spirituelles, sociales et symboliques de la souffrance.

La convergence entre anthropologie médicale africaine et théologie islamique inculturée offre un cadre éthique puissant : protection du vulnérable, refus de la stigmatisation, centralité de la miséricorde.

Dans une perspective soufie, chaque cas apparaît comme un voyage intérieur, une traversée de l'épreuve vers une présence plus consciente à Dieu et aux autres. Ainsi, la MTHS ne se contente pas de soigner des individus : elle répare des liens, restaure des paroles et réinscrit la souffrance dans un horizon de sens.

Conclusion du chapitre

Les études de cas cliniques présentées dans ce chapitre constituent la preuve vivante que la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels est une voie crédible de guérison intégrale. En conjuguant rigueur clinique, sagesse africaine et spiritualité islamique, elle ouvre un chemin thérapeutique profondément humain, où la délivrance ne sépare jamais l'homme de sa communauté ni de son Créateur.

CHAPITRE-15 :
PREVENTION DURABLE ET
RESPONSABILITE RELIGIEUSE EN MTHS

INTRODUCTION

De la guérison à la vigilance responsable

Dans les sociétés africaines traditionnelles, la guérison n'a jamais été comprise comme un événement ponctuel, mais comme un processus continu qui engage l'individu, la famille, la communauté et le rapport au sacré. Être guéri ne signifie pas être définitivement à l'abri, mais être réintroduit dans une dynamique de vigilance, de responsabilité et de discernement. Cette sagesse ancienne rejoint profondément l'enseignement islamique selon lequel la foi authentique n'est pas une simple adhésion émotionnelle, mais un chemin de conscience, d'équilibre et de persévérance.

Dans le cadre de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, la prévention apparaît ainsi comme l'aboutissement logique et éthique de tout processus thérapeutique. Après la cure de désenvoûtement, la délivrance spirituelle et l'accompagnement psychosocial, il devient impératif de consolider les acquis, de réduire les facteurs de rechute et de protéger les personnes et les communautés contre les dérives religieuses et spirituelles.

Ce chapitre se veut un espace de maturation. Il invite à passer d'une logique de réaction à une logique de prévention

durable, d'une foi défensive à une foi responsable, d'une dépendance thérapeutique à une autonomie spirituelle éclairée. Nourri par la théologie islamique, la sagesse soufie, l'anthropologie médicale africaine et l'expérience clinique de la MTHS, il adopte une écriture immersive, presque initiatique, afin que le lecteur ne soit pas seulement informé, mais intérieurement transformé.

I. FONDEMENTS THEOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES DE LA PREVENTION SPIRITUELLE

1. La prévention comme exigence coranique

Le Coran appelle constamment le croyant à la vigilance et à la responsabilité personnelle et collective. **« Ô vous qui avez cru ! Prenez garde à vous-mêmes » (Coran 5:105).** Cette injonction n'invite pas à l'isolement spirituel, mais à une conscience lucide des fragilités humaines et des dérives possibles lorsqu'elles ne sont pas accompagnées.

Dans la MTHS, la prévention est comprise comme un acte de miséricorde. Prévenir, c'est protéger avant que la souffrance ne s'installe, c'est discerner avant que la peur ne devienne pathologique, c'est enseigner avant que l'ignorance ne soit exploitée. Cette perspective rejoint l'anthropologie africaine, où le sage est celui qui voit venir le déséquilibre avant qu'il ne devienne visible.

2. La *taqwâ* comme socle de la prévention durable

La *taqwâ*, souvent traduite par crainte révérencielle ou conscience de Dieu, constitue le cœur de la prévention spirituelle en Islam. Elle n'est pas peur paralysante, mais vigilance aimante. Elle éduque le croyant à reconnaître ses limites, à éviter les excès et à rechercher l'équilibre.

Dans la sagesse africaine, cette disposition intérieure correspond à l'idée de cœur éveillé, attentif aux signes, respectueux des forces visibles et invisibles. La MTHS articule ces deux traditions pour former une prévention enracinée à la fois dans la foi et dans la culture.

II. FORMATION DES IMAMS : PILIERS DE LA PREVENTION COMMUNAUTAIRE

1. L'imam, éducateur et veilleur spirituel

En Afrique noire, l'imam occupe une place centrale qui dépasse largement la conduite de la prière. Il est conseiller familial, médiateur social, interprète des épreuves spirituelles et repère moral pour la communauté. Cette position confère une responsabilité immense, notamment dans la prévention des handicaps spirituels.

La MTHS considère l'imam comme un acteur clé de la prévention durable. Sa formation doit donc intégrer non seulement la théologie classique, mais aussi l'anthropologie médicale africaine,

l'éthique thérapeutique et le discernement spirituel face aux phénomènes d'envoûtement et de sorcellerie.

2. Intégrer la MTHS dans les parcours de formation religieuse

Former les imams à la MTHS signifie leur offrir des outils concrets pour reconnaître les signes précoces de détresse spirituelle, orienter les fidèles sans stigmatisation et éviter les accusations abusives. Cette formation encourage une collaboration éthique avec des praticiens traditionnels responsables, dans le respect strict du monothéisme islamique.

Elle permet également d'éviter les réponses simplistes ou violentes aux souffrances spirituelles, en privilégiant l'écoute, la pédagogie et la protection des personnes vulnérables.

3. L'apport soufi : purifier l'intention et discipliner le pouvoir

La tradition soufie rappelle que toute fonction spirituelle comporte un risque : celui de l'orgueil, de la domination ou de l'instrumentalisation de la foi. La prévention commence donc par la purification de l'intention (*niyya*). L'imam formé devient un serviteur et non un maître, un guide et non un possesseur des consciences.

III. AUTONOMIE SPIRITUELLE DES FIDELES : PREVENIR LA DEPENDANCE THERAPEUTIQUE

1. Comprendre les mécanismes de dépendance spirituelle

Après une délivrance ou une cure de désenvoûtement, certains fidèles développent une dépendance excessive au thérapeute ou au guide religieux. Cette dépendance fragilise la personne et ouvre la voie à de nouvelles formes d'exploitation.

La MTHS affirme que la guérison authentique conduit toujours à l'autonomie spirituelle. Le fidèle est appelé à devenir responsable de sa relation à Dieu, soutenu par la communauté mais non soumis à une autorité absolue.

2. Enseigner des pratiques de protection accessibles

L'autonomie spirituelle se construit par l'apprentissage de pratiques simples : prières régulières, récitations coraniques protectrices, hygiène relationnelle, discipline morale et gestion saine de la peur de l'invisible. Ces pratiques rejoignent la sagesse africaine de l'équilibre quotidien.

3. Responsabiliser sans culpabiliser

La prévention ne doit jamais devenir un instrument de culpabilisation. L'Islam rappelle que Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses capacités. La MTHS privilégie une pédagogie progressive, miséricordieuse et libératrice.

IV. LUTTE CONTRE L'EXPLOITATION RELIGIEUSE : UNE URGENCE ETHIQUE

1. Marchandisation de la peur et dérives contemporaines

Dans de nombreux contextes africains, la peur de la sorcellerie est exploitée à des fins économiques et de pouvoir. Promesses de protection conditionnées à des paiements excessifs, discours alarmistes et rituels interminables constituent autant de formes d'exploitation religieuse.

L'Islam condamne fermement ces pratiques, rappelant que la guidance appartient à Dieu seul et que la foi ne peut être monnayée.

2. Éduquer au discernement communautaire

La prévention passe par l'éducation des fidèles à reconnaître les signes d'abus : discours de peur permanente, isolement du fidèle, absence de pédagogie et enrichissement ostentatoire des guides spirituels.

3. Responsabilité collective et protection des vulnérables

La lutte contre l'exploitation religieuse est une responsabilité collective. Imams, familles et leaders communautaires doivent coopérer pour protéger les plus fragiles et restaurer une foi libératrice.

V. RECIT INITIATIQUE :

Devenir gardien du seuil

Dans certaines traditions africaines, celui qui a traversé la nuit devient gardien du seuil. Il ne combat pas les ombres par la violence, mais par la vigilance. Ainsi en est-il du fidèle guéri : il devient veilleur pour lui-même et pour les autres.

Ce récit initiatique illustre la finalité de la prévention en MTHS : transformer l'épreuve en sagesse et la guérison en responsabilité collective.

CONCLUSION

La prévention et la responsabilité religieuse constituent l'horizon éthique de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels. Former les imams, autonomiser les fidèles et lutter contre l'exploitation religieuse ne sont pas des options secondaires, mais des exigences fondamentales pour une foi incarnée, protectrice et libératrice.

Dans une Afrique confrontée à la peur de l'invisible et aux dérives spirituelles, cette approche inculturée de l'Islam, nourrie de sagesse africaine, ouvre un chemin de maturité, de dignité humaine et de paix durable.

CHAPITRE-16 :

GUIDE DE FORMATION DES IMAMS ET LEADERS COMMUNAUTAIRES EN MTHS

INTRODUCTION

Former pour protéger, guider et libérer

Dans de nombreuses sociétés africaines, l'imam ou le leader religieux joue un rôle central dans la vie spirituelle et sociale de la communauté. Il est conseiller moral, médiateur dans les conflits, guide pour les jeunes et dépositaire de la parole sacrée. Sa responsabilité dépasse donc la simple conduite des prières : il devient acteur de santé spirituelle, médiateur communautaire et garant de l'harmonie sociale.

L'expérience des handicaps spirituels – manifestations de détresse psychique ou spirituelle dues à des influences maléfiques, des envoûtements, des malédictions, ou des déséquilibres relationnels – révèle à quel point le rôle des leaders religieux est crucial. Sans formation, ils peuvent involontairement alimenter la peur, renforcer les stigmatisations et créer des situations d'exclusion sociale. La MTHS propose un cadre rigoureux pour former les imams et leaders communautaires afin de prévenir ces dérives et protéger les plus vulnérables.

Ce guide pédagogique est une **adaptation de l'ouvrage MTHS**, calibrée pour une formation pratique et interactive. Il articule la **théologie islamique, la sagesse soufie, l'anthropologie médicale africaine et la médecine traditionnelle** pour fournir aux

leaders religieux des outils de prévention, d'accompagnement et de discernement.

Objectifs généraux de la formation

Les participants à cette formation développeront des compétences permettant de :

1. Comprendre les fondements théologiques et anthropologiques du handicap spirituel.
2. Prévenir la détresse spirituelle avant qu'elle ne devienne un handicap durable.
3. Accompagner les fidèles et les familles sans stigmatisation.
4. Collaborer avec des praticiens traditionnels dans un cadre éthique.
5. Détecter et combattre l'exploitation religieuse et les abus de pouvoir spirituel.
6. Favoriser l'autonomie spirituelle des fidèles tout en maintenant la cohésion communautaire.

Ces objectifs traduisent une vision holistique où **la prévention, la protection et la responsabilité sont au cœur de l'action religieuse.**

ARCHITECTURE PEDAGOGIQUE ET MODULES DE FORMATION

MODULE-1 – FONDEMENTS THEOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIE SPIRITUELLE AFRICAINE

Objectif pédagogique : Unifier foi islamique et culture africaine dans la compréhension de l'être humain.

Contenu :

- La conception coranique de l'être humain comme *khalîfa*, dépositaire d'une *amânah* (dépôt sacré) et porteur de dignité divine (Coran 95:4, 15:29).
- La personne humaine comme carrefour de relations visibles et invisibles : relations familiales, clan, communauté, ancêtres, forces spirituelles et lien avec Dieu.
- L'anthropologie médicale africaine : maladie et déséquilibre spirituel comme phénomène relationnel.
- Notion de handicap spirituel : manifestations, causes et conséquences dans le contexte africain.

Compétences développées :

- Comprendre le caractère holistique de la personne.
- Identifier les signes précoces de déséquilibre spirituel.
- Relier la théologie islamique aux réalités culturelles locales.

MODULE-2 : LECTURE ISLAMIQUE DE LA SORCELLERIE ET DE L'ENVOUTEMENT

Objectif pédagogique : Sortir des représentations erronées et éviter les accusations abusives.

Contenu :

- Analyse du *sihr* et de l'influence maléfique dans le Coran et la Sunna.
- Limites de l'accusation et mise en garde contre les conjectures excessives (Coran 49:12).
- Approche éthique de l'intervention spirituelle : prévenir les erreurs judiciaires et morales.
- Rôle des imams dans la médiation et la prévention des violences symboliques.

Compétences développées :

- Discerner le vrai du faux dans les accusations de sorcellerie.
- Appliquer une approche théologique respectueuse et éthique.
- Prévenir la peur collective et la stigmatisation.

MODULE-3 : BASES DE LA MTHS : CURE, DELIVRANCE ET SUIVI

Objectif pédagogique : Comprendre la logique thérapeutique et le rôle de l'imam.

Contenu :

- Présentation de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels : principes, objectifs et limites.
- Cure de désenvoûtement et délivrance spirituelle : cadre éthique et protection des patients.
- Suivi psychosocial et communautaire : réintégration et prévention des rechutes.
- Coordination avec les thérapeutes traditionnels et respect de l'éthique religieuse.

Compétences développées :

- Orienter le fidèle vers une prise en charge appropriée.
- Maintenir l'équilibre entre guidance spirituelle et autonomie du patient.
- Superviser le processus de guérison avec discernement.

MODULE-4 : PROTECTION DU PATIENT ET SECRET THERAPEUTIQUE

Objectif pédagogique : Prévenir la stigmatisation et les violences sociales.

Contenu :

- Secret thérapeutique en Islam (*satr*) : principes et application.
- Gestion communautaire de l'information : prudence et respect de la dignité.
- Médiation familiale et maintien du lien social.
- Règles éthiques pour les imams et leaders lors des interventions.

Compétences développées :

- Protéger les personnes vulnérables.
- Maintenir la confidentialité et la discrétion.
- Prévenir la diffusion de rumeurs ou accusations.

MODULE-5 : DESAMORÇAGE DES ACCUSATIONS ET RECONCILIATION COMMUNAUTAIRE

Objectif pédagogique : Restaurer la paix sociale et réduire la peur.

Contenu :

- Principes de *islah* : réconciliation selon le Coran et la Sunna.
- Techniques de médiation dans le contexte africain : repas communautaires, paroles publiques de pardon, cérémonies de purification symbolique.
- Rôle du leader religieux comme médiateur et guide.

Compétences développées :

- Réduire les tensions et prévenir les conflits.
- Créer un environnement sécurisant pour le patient et sa famille.
- Restaurer la confiance et le lien social.

MODULE-6 : AUTONOMIE SPIRITUELLE DES FIDELES

Objectif pédagogique : Prévenir la dépendance religieuse et renforcer la responsabilité individuelle.

Contenu :

- Pratiques personnelles de protection : prières régulières, récitations coraniques, discipline morale et hygiène relationnelle.
- Construction d'une foi mature et équilibrée.
- Techniques pédagogiques pour responsabiliser les fidèles sans culpabilisation.
- Suivi progressif vers l'autonomie : de l'accompagnement direct à l'auto-veille spirituelle.

Compétences développées :

- Former des fidèles capables de discernement.
- Maintenir l'équilibre entre guidance et autonomie.
- Renforcer la résilience spirituelle individuelle et communautaire.

MODULE-7 : LUTTE CONTRE L'EXPLOITATION RELIGIEUSE

Objectif pédagogique : Identifier et prévenir les abus de pouvoir et la marchandisation de la foi.

Contenu :

- Reconnaître les pratiques abusives : promesses conditionnelles, rituels financiers excessifs, isolement et intimidation.
- Règles éthiques pour les imams et leaders : respect de la liberté de conscience, non-domination et transparence.
- Collaboration communautaire pour protéger les plus vulnérables.
- Exemples de cas et solutions adaptées selon les principes coraniques et soufis.

Compétences développées :

- Détecter les signes d'exploitation.
- Intervenir de manière éthique et efficace.
- Former des communautés responsables et vigilantes.

MODULE-8 : ÉTUDES DE CAS ET DISCERNEMENT PRATIQUE

Objectif pédagogique : Ancrer la formation dans la réalité concrète.

Contenu :

- Présentation de cas cliniques anonymisés basés sur la pratique MTHS.
- Analyse théologique, psychologique et communautaire.
- Décision éthique : orientation, médiation, prévention et réintégration.
- Simulations et exercices pratiques pour renforcer les compétences décisionnelles.

Compétences développées :

- Prendre des décisions éclairées dans des situations complexes.
- Appliquer la théologie et l'éthique à des cas réels.
- Prévenir les conséquences sociales négatives et restaurer l'équilibre communautaire.

METHODOLOGIE DE FORMATION

- Enseignement interactif avec échanges et débats.
- Études de cas réels et simulations.
- Cercles de parole pour développer l'écoute et la sensibilité.
- Temps de *dhikr* et de réflexion intérieure pour relier théorie et pratique.
- Suivi post-formation pour évaluer l'intégration des compétences dans la pratique.

Évaluation et certification

L'évaluation combine :

- Compréhension théologique et anthropologique.
- Capacité de discernement dans des situations complexes.
- Respect de l'éthique et du secret thérapeutique.
- Engagement communautaire et actions de prévention.

Une **attestation l'Association Mariale d'Abili (ASMAB)** certifie la capacité à agir comme leader formé à la prévention et à l'accompagnement des handicaps spirituels selon la MTHS.

CONCLUSION

Former des gardiens de la vie et de la foi

Former les imams et leaders communautaires à la MTHS, c'est investir dans la paix sociale, la protection des vulnérables et l'élévation spirituelle des fidèles. Le leader formé devient un **gardien de la vie**, un veilleur du lien social et un témoin d'un Islam incarné, miséricordieux et libérateur.

Ce guide constitue un outil vivant, transformant la connaissance en responsabilité, la foi en service et la guérison individuelle en sagesse collective. Il permet à chaque participant de devenir acteur de la prévention, garant de la dignité humaine et artisan d'une foi pleinement incarnée dans la culture africaine et les principes islamiques.

CONCLUSION GÉNÉRALE DU LIVRE

Aboutissement méthodologique et appel à un Islam africain
thérapeutique

La fin d'un parcours et le commencement d'une responsabilité

Il est des moments dans la vie de l'esprit et du corps où l'on sent que tout chemin parcouru n'est pas seulement une succession de gestes et de pratiques, mais une ascension intérieure. La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS), telle que conceptualisée et pratiquée selon les principes islamiques inculturés à l'Afrique, nous conduit à ce moment précis. La conclusion de cet ouvrage n'est pas une fin : elle est l'aboutissement méthodologique de toutes les démarches cliniques, éthiques et spirituelles que nous avons explorées, et l'ouverture sur une responsabilité nouvelle, celle d'un Islam africain, thérapeutique, équilibré et miséricordieux.

Dans cette conclusion, le lecteur est invité à un retour réflexif, presque initiatique : comprendre comment chaque élément méthodologique de la MTHS converge vers la restauration de la dignité humaine, et comment, dans le contexte africain, l'Islam peut devenir un instrument de guérison collective, de paix et de miséricorde.

I. ABOUTISSEMENT METHODOLOGIQUE DE LA MTHS ISLAMIQUE

1. De la théorie à la pratique : un parcours intégré

La MTHS n'est pas une simple juxtaposition de techniques thérapeutiques. Elle constitue un **chemin méthodologique intégré**, où la théologie, la médecine traditionnelle, la psychologie spirituelle

et l'anthropologie se rencontrent. Chaque patient devient un point d'intersection entre le visible et l'invisible, le corps et l'âme, l'individuel et le collectif.

Dans cette approche, la démarche clinique suit plusieurs étapes coordonnées :

- **Identification et compréhension du handicap spirituel** : reconnaissance des symptômes, évaluation des causes visibles et invisibles, et discernement des influences spirituelles à l'œuvre.
- **Intervention thérapeutique ciblée** : cure de désenvoûtement, délivrance spirituelle, accompagnement émotionnel et spirituel, tout en respectant l'éthique islamique et la dignité du patient.
- **Suivi psychosocial et communautaire** : protection contre la stigmatisation, médiation dans les conflits, restauration des liens sociaux et familiaux.

Chaque étape est **imbriquée et interdépendante**, formant un processus continu de guérison. Le patient n'est jamais isolé : il est suivi, accompagné et réintégré, dans une logique où la restauration de l'âme et de la communauté se fait simultanément.

2. La dimension coranique et soufie de la méthodologie

L'approche MTHS s'enracine profondément dans les enseignements coraniques et la sagesse soufie :

- Le **Coran** reconnaît la vulnérabilité humaine et appelle à la protection des faibles : « Dieu ne charge personne au-delà de sa capacité » (Coran 2:286). Cette idée soutient la nécessité d'un accompagnement patient et méthodique.
- La **sagesse soufie** insiste sur l'équilibre intérieur (*sukûn*) et la proximité avec Dieu (*qurb*), qui doivent guider toute démarche thérapeutique. Le soufi observe l'âme, accompagne le cœur et met la compassion au centre de l'action.
- L'**inculturation africaine** permet d'intégrer les symboles, rituels et pratiques locales, tout en respectant l'unicité de Dieu et l'éthique islamique. Le patient retrouve ainsi un espace de soin qui est à la fois spirituel, social et culturel.

3. Les enseignements méthodologiques essentiels

Trois enseignements clés émergent :

1. **La protection du patient est la priorité absolue** : tant sur le plan spirituel que social.
2. **La guérison ne se réduit pas au soulagement des symptômes** : elle implique une réintégration dans la communauté et la restauration de la dignité.
3. **La méthodologie est holistique et itérative** : elle combine observation, intervention et réévaluation constante, en dialogue permanent avec les principes coraniques et la culture locale.

II. RESTAURER LA DIGNITE DU MUSULMAN FACE A LA PEUR

1. La peur : un obstacle universel

Dans de nombreux contextes africains, la peur de l'invisible domine les consciences. Elle se manifeste sous forme de suspicion, d'accusations de sorcellerie, d'exclusion sociale et parfois de violence. Cette peur n'est pas seulement individuelle : elle est **collective**, elle fragilise le tissu social et met en danger les relations communautaires.

Le musulman atteint par un handicap spirituel se retrouve souvent **dépossédé de sa voix et de sa place**. La peur envahit son cœur et celui de son entourage. La première responsabilité de la MTHS est de **restituer la dignité de l'être humain** : permettre au patient de retrouver la parole, le souffle, et la capacité à exister sans crainte dans son environnement.

2. L'accompagnement méthodique de la restauration

La restauration de la dignité passe par plusieurs étapes, articulées méthodologiquement :

- **Protection et secret** : préserver l'intimité et la vulnérabilité du patient.
- **Désamorçage des accusations** : médiation communautaire et rappel des enseignements coraniques sur le discernement et l'éthique.

- **Réhabilitation sociale** : restauration des liens, attribution de responsabilités et participation active aux activités communautaires.

Chaque action vise à **transformer la peur en confiance**, l'angoisse en sécurité, et le rejet en inclusion.

3. La dimension spirituelle

La dignité retrouvée est inséparable de la **proximité avec Dieu**. Le patient, guidé par les rituels licites, la prière, le *dhikr* et la méditation, retrouve un **centre de gravité intérieur**. La peur n'est plus paralysante : elle devient un moteur de vigilance et de responsabilité. L'accompagnement méthodologique devient ainsi **éthique, thérapeutique et spirituel**, offrant une reconstruction complète de l'être.

III. APPEL A UN ISLAM AFRICAIN THERAPEUTIQUE, EQUILIBRE ET MISERICORDIEUX

1. L'Islam africain comme Islam vivant

L'Afrique, par sa richesse culturelle et ses traditions ancestrales, offre un terrain propice à un Islam **inculturé, vivant et thérapeutique**. Il ne s'agit pas de syncrétisme, mais de **reconnaître et intégrer les codes symboliques et les pratiques locales** dans le respect strict de l'éthique islamique.

Un Islam africain thérapeutique doit répondre à trois exigences :

1. **Équilibre** : entre rigueur religieuse et compassion sociale.
2. **Miséricorde** : centrée sur la protection des faibles, la guérison des cœurs et la réintégration sociale.
3. **Responsabilité** : chaque leader religieux devient acteur de prévention, médiateur et garant de la dignité humaine.

2. Formation et sensibilisation des acteurs religieux

Le guide et les modules précédemment proposés montrent que **former les imams et leaders communautaires** est crucial. Ils deviennent les **gardien(ne)s de la prévention**, capables de détecter les signes de détresse spirituelle, d'appliquer les principes coraniques, et d'accompagner les fidèles sans abus ni exploitation.

La formation doit inculquer :

- la connaissance théologique et anthropologique,
- le discernement clinique et éthique,
- la capacité à restaurer la dignité et les liens sociaux,
- la vigilance contre les pratiques abusives ou mercantiles.

3. La communauté comme acteur de guérison

Dans cet Islam africain, la **communauté n'est plus spectatrice** mais acteur : elle participe à la protection, à la réintégration et à la prévention des rechutes. La guérison n'est complète que lorsque le patient retrouve sa place et que la peur se transforme en solidarité.

4. Mise en pratique : exemples et récits initiatiques

Des récits initiatiques africains, où l'homme frappé par l'ombre retrouve sa voix et son souffle, illustrent le processus. La méthodologie MTHS, combinée à la guidance religieuse, permet que chaque membre vulnérable redevienne **un pilier de la communauté**, tout en cultivant une foi équilibrée, consciente de ses limites et de sa miséricorde.

IV. Synthèse et recommandations finales

1. La méthodologie MTHS en un regard

- Observation rigoureuse et respectueuse.
- Intervention thérapeutique licite et guidée par le Coran et la Sunna.
- Suivi psychosocial et réintégration communautaire.
- Prévention et formation des leaders religieux.

Chaque étape est articulée pour protéger, restaurer et responsabiliser.

2. Restaurer la dignité : un impératif coranique et éthique

- L'accompagnement méthodologique permet au musulman de **retrouver sa voix et sa place**.
- La peur n'est plus un obstacle paralysant mais un élément transformé en vigilance et engagement.
- L'éthique islamique, la sagesse soufie et la culture africaine se rejoignent pour **protéger l'être humain**.

3. Vers un Islam africain thérapeutique

- Formation des imams et leaders communautaires.
- Responsabilisation des fidèles.
- Promotion de la miséricorde, de la compassion et de la justice.
- Prévention de l'exploitation religieuse.
- Réconciliation entre tradition, foi et culture.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, lorsqu'elle est **islamique et inculturée**, ne se limite pas à guérir un symptôme ou un mal invisible. Elle constitue un chemin méthodologique, un **art de restaurer la dignité, de protéger la vulnérabilité et de transformer la peur en force sociale et spirituelle**. Ce chemin conduit à un **Islam africain thérapeutique, équilibré et miséricordieux**, capable de répondre aux besoins spirituels, sociaux et psychiques de la communauté. Il appelle chaque imam, leader communautaire et fidèle à devenir **gardien de la vie, artisan de paix et témoin d'une foi qui soigne autant les corps que les âmes**.

Ainsi s'achève l'ouvrage, non comme une fin, mais comme **l'ouverture sur une responsabilité collective et une pratique religieuse incarnée**, qui fait de la guérison spirituelle une aventure humaine, sociale et initiatique, ancrée dans la sagesse africaine et les principes coraniques.

ANNEXES CLINIQUES – MEDECINE TRADITIONNELLE DES HANDICAPES SPIRITUELS (MTHS) ISLAMIQUE

Introduction

Les annexes cliniques complètent l'ouvrage ASMAB – Sagesse Africaine en offrant des outils pratiques, méthodologiques et éthiques aux praticiens de la MTHS dans un contexte musulman et africain. Elles visent à :

- Standardiser les entretiens et les suivis.
- Fournir des indicateurs précis de progression et de guérison.
- Garantir une pratique respectueuse de l'éthique islamique et culturelle.

Ces annexes ne sont pas de simples documents techniques ; elles incarnent l'esprit de la MTHS : une médecine spirituelle, holistique et inculturée.

I. GRILLE D'ENTRETIEN MTHS ISLAMIQUE

La grille d'entretien est un outil d'évaluation initiale, permettant de recueillir des informations complètes et de structurer l'accompagnement du patient.

1. Informations personnelles et contexte familial

- Nom, âge, sexe, lieu de résidence.
- Structure familiale et relations importantes.
- Antécédents médicaux et spirituels.
- Rôle social et communautaire.

2. Histoire spirituelle et religieuse

- Pratiques religieuses quotidiennes et niveau de foi.
- Expériences de vulnérabilité ou de peur liées à l'invisible.
- Épisodes de déséquilibre spirituel, crises ou incidents.
- Relations avec les leaders religieux et guides spirituels.

3. Manifestations cliniques et symptômes

- Troubles du sommeil, anxiété, peurs irrationnelles.
- Perte de voix, apathie, isolement social.
- Perceptions spirituelles anormales ou perturbantes.
- Expériences de malédictions, envoûtements ou influences négatives.

4. Évaluation du contexte communautaire

- Accusations ou suspicions de sorcellerie.
- Niveau de soutien familial et social.
- Relations avec la communauté religieuse.
- Risques de marginalisation ou d'exclusion.

5. Objectifs thérapeutiques et attentes

- Espoirs et besoins du patient.
- Attentes familiales et communautaires.
- Objectifs spirituels : purification, réconciliation, réintégration.

6. Observations et recommandations initiales

- Points forts et vulnérabilités.
- Nécessité de protection ou de médiation.
- Plan d'intervention préliminaire selon l'approche MTHS.

II. INDICATEURS DE GUERISON

Les indicateurs de guérison sont essentiels pour **suivre la progression du patient** et évaluer l'efficacité de l'intervention MTHS.

1. Indicateurs spirituels

- Reprise des pratiques religieuses régulières (prière, dhikr, lecture coranique).
- Réduction des peurs irrationnelles et des obsessions spirituelles.
- Capacité à faire confiance aux guides et à Dieu.
- Sens accru de responsabilité morale et éthique.

2. Indicateurs psychologiques

- Retrouver un sommeil normal et la sérénité intérieure.
- Capacité à gérer le stress et les émotions.
- Expression verbale et communication saine.
- Émergence d'une confiance en soi et d'une estime personnelle.

3. Indicateurs sociaux

- Réintégration dans la famille et la communauté.
- Participation active aux activités sociales et religieuses.
- Résolution des conflits et apaisement des tensions.
- Réduction ou disparition des accusations de sorcellerie.

4. Indicateurs culturels et anthropologiques

- Acceptation des rituels licites et des symboles culturels adaptés.
- Respect des codes sociaux et traditions locales sans compromettre la foi.
- Capacité à utiliser des pratiques culturelles comme soutien thérapeutique.

5. Indicateurs cliniques

- Stabilisation des symptômes psychiques et spirituels.
- Disparition des manifestations physiques liées au stress ou à la peur.
- Réponse positive aux séances de délivrance et aux interventions thérapeutiques.

III. CHARTE ETHIQUE DU PRATICIEN MTHS EN CONTEXTE MUSULMAN

Le praticien MTHS doit se conformer à une éthique stricte, intégrant la théologie, la culture et la protection des droits humains.

1. Principes fondamentaux

- **Respect de la dignité humaine** : chaque patient est un dépositaire de l'amânah divine.
- **Confidentialité et discrétion** : aucune information n'est divulguée sans consentement.
- **Non-exploitation** : aucune pratique ne doit viser un profit personnel au détriment du patient.
- **Conformité à l'Islam** : les interventions respectent le Coran, la Sunna et la tradition soufie.

2. Responsabilités professionnelles

- Assurer une **écoute attentive** et un suivi rigoureux.
- Adapter les interventions aux réalités culturelles locales.
- Coopérer avec les familles, la communauté et les leaders religieux.
- Intervenir uniquement dans le cadre de ses compétences et orienter vers d'autres praticiens si nécessaire.

3. Engagement moral et spirituel

- Traiter chaque patient avec **compassion et patience**, considérant le soin comme un acte de foi.
- Prévenir et désamorcer tout conflit ou accusation injustifiée.
- Utiliser les pratiques rituelles et symboliques de manière responsable et licite.
- Maintenir un apprentissage continu et un discernement constant pour éviter les erreurs.

4. Surveillance et auto-évaluation

- Tenir un journal de suivi et d'observation des interventions.
- Évaluer régulièrement l'efficacité et l'impact social et spirituel des actions.
- Rechercher la supervision ou le conseil auprès de guides expérimentés.
- S'assurer que la pratique ne s'écarte jamais de l'éthique islamique et de la protection de la communauté.

IV. NARRATION ET PERSPECTIVE INITIATIQUE

Chaque grille, indicateur ou charte ne doit pas être perçue comme un simple instrument technique. Dans la logique MTHS, ces outils incarnent **une pédagogie spirituelle et pratique** :

- **La grille d'entretien** devient un dialogue initiatique, où le praticien apprend à écouter non seulement les mots, mais les silences, les peurs et les espoirs.
- **Les indicateurs de guérison** ne mesurent pas seulement la disparition des symptômes ; ils reflètent la reconstruction progressive du cœur, du souffle et de la confiance.
- **La charte éthique** est un guide moral et spirituel, rappelant que le soin est un acte de foi, de miséricorde et de responsabilité communautaire.

Ainsi, le praticien MTHS devient **un artisan de la réconciliation entre le visible et l'invisible**, entre la foi et la culture, entre le patient et sa communauté. Chaque intervention est un récit, chaque suivi une initiation à la sagesse, chaque restauration une victoire sur la peur et la marginalisation.

RESUMÉ

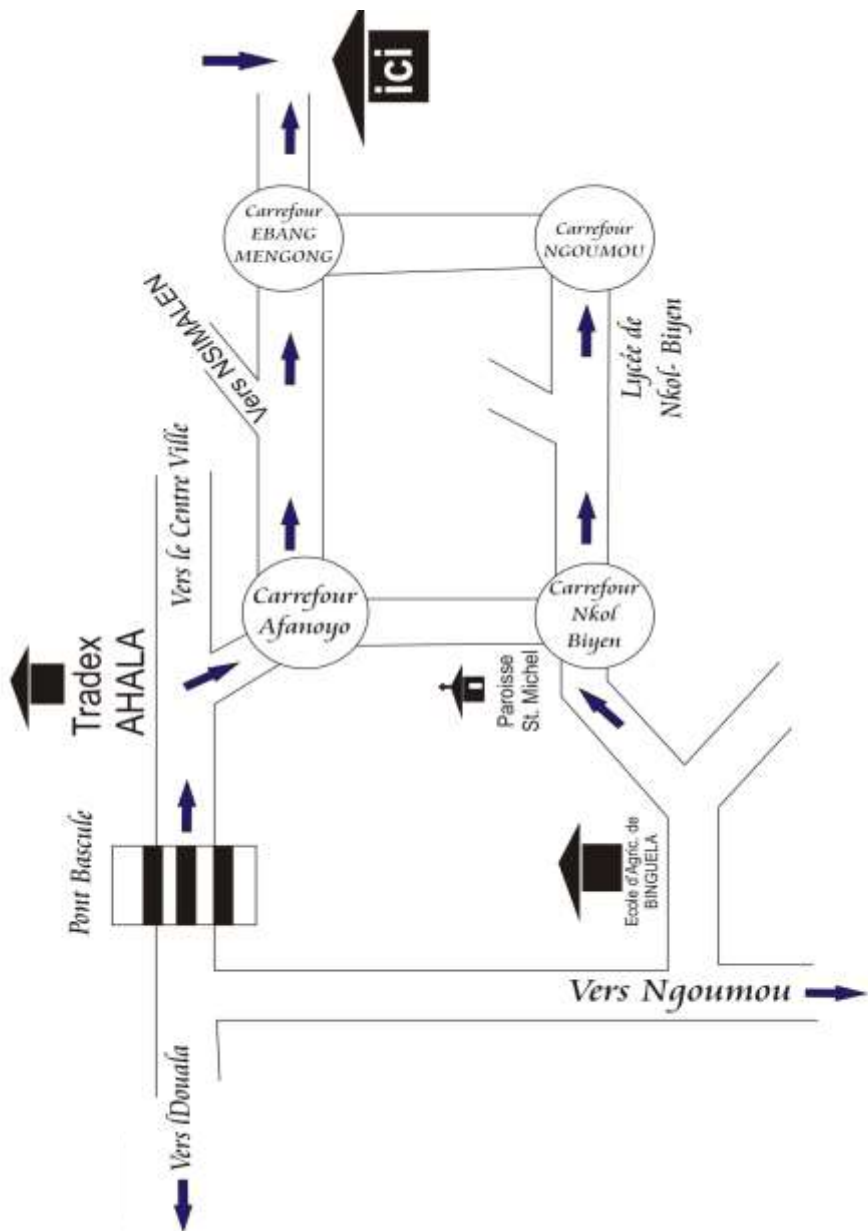
Les annexes cliniques de la MTHS islamique offrent un **cadre méthodologique, éthique et spirituel complet**. Elles permettent de :

1. Standardiser et sécuriser les interventions.
2. Mesurer la progression spirituelle, psychologique et sociale.
3. Maintenir une pratique éthique conforme à l'Islam et respectueuse des cultures africaines.

L'utilisation de ces outils transforme chaque séance de MTHS en un **chemin initiatique** pour le praticien et le patient. Elle assure que la médecine spirituelle ne reste pas théorique, mais qu'elle se traduit en **actions concrètes de protection, de guérison et de restauration de la dignité**.

En suivant cette approche, le praticien contribue à un **Islam africain thérapeutique, équilibré et miséricordieux**, capable de répondre aux défis spirituels, psychiques et sociaux des communautés africaines contemporaines.

Ces annexes, lorsqu'elles sont appliquées avec discernement et foi, deviennent un **pont entre la tradition, la théologie et la vie quotidienne**, permettant à la MTHS de remplir pleinement sa vocation : guérir les cœurs, rétablir les liens et instaurer une paix durable au sein des communautés.



PLAN de localisation du Centre de **Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels** « **MARIE REINE DE LA MISERICORDE D'ABILI** » au CAMEROUN
 TEL: (00237) 641 42 99 18 / (00237) 677 75 73 56

Dans l'Afrique contemporaine, la sorcellerie n'est pas un mythe. Elle traverse les familles, fragilise les esprits et met à l'épreuve les liens communautaires. Les victimes, souvent isolées, vivent la peur, la stigmatisation et la marginalisation. Les communautés, elles, cherchent des réponses entre traditions ancestrales et exigences religieuses.

Le Musulman face à la sorcellerie offre une approche clinique et méthodologique inédite à travers la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS). Fondé sur la théologie islamique, la sagesse soufie et l'anthropologie africaine, ce livre guide praticiens, imams et leaders communautaires dans l'identification des situations spirituelles, l'accompagnement des patients et leur réintégration harmonieuse.

Grâce à des outils pratiques, grilles d'entretien, indicateurs de guérison et charte éthique, il montre comment transformer la peur en compréhension, la solitude en soutien collectif et la souffrance spirituelle en force de vie et de cohésion sociale.

Un guide initiatique et thérapeutique, pour un Islam africain miséricordieux, équilibré et profondément humain, capable de restaurer dignité, foi et harmonie dans les communautés.



ISBN 978-9956-733-26-3



En l'an 2000, Jean Paul Sylvain SIDA ABENA a reçu du Seigneur JESUS CHRIST la mission et les pleins pouvoirs de dévoiler au grand jour tous les secrets du Diable, le Malin, afin de sortir les hommes de la prison de l'ignorance qui les maintient dans la persécution du Diable, des démons et du phénomène de la sorcellerie.

Jean Paul Sylvain SIDA ABENA est le Fondateur du Centre de traitements spirituels "MARIE REINE DE LA MISERICORDE D'ABILI", dans l'arrondissement de BIKOK (CAMEROUN). Il est le Précurseur de trois disciplines scientifiques :

- 1- L'Etude Systématique de l'Esprit Humain,
- 2- La SORCIORLOGIE : l'Etude des comportements de déviance, des déviations spirituelles et des évolutions spirituelles du phénomène de la sorcellerie,
- 3- La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) dont la Mission est de : « Guérir l'âme, restaurer le corps, libérer l'esprit ». Il s'agit d'une médecine inculturée qui associe Tradition, nature et spiritualité au service de la Santé Holistique.

À ce jour, cette médecine est actuellement codifiée, documentée, enseignée et diffusée par l'Association Mariale d'ABILI (ASMAB).